

社会医学

华西大纲 · PPT · 历年真题整理
复习笔记

2026 年 6 月 25 日

greedyCat

使用说明	4
第一章 绪论	5
1.1 社会医学的概念、内容与任务	5
1.1.1 社会医学的概念	5
1.1.2 研究对象与内容	5
1.1.3 三次卫生革命	5
1.1.4 社会医学的任务	6
1.2 社会医学的发展	6
1.2.1 萌芽与西方发展	6
1.2.2 我国社会医学的发展	6
1.3 社会医学的特色理论与创新观点	6
1.4 复习题	7
第二章 医学模式	8
2.1 医学模式的概念	8
2.2 医学模式的演变	8
2.3 生物-心理-社会医学模式与健康观	8
2.3.1 产生背景	8
2.3.2 生物-心理-社会医学模式的内涵（难点*）	9
2.3.3 健康观	9
2.4 复习题	10
第三章 健康社会决定因素	11
3.1 健康社会决定因素概述	11
3.1.1 基本概念	11
3.1.2 理论发展历程	11
3.2 健康社会决定因素的框架与内容	11
3.2.1 理论模型与行动框架	11
3.2.2 社会因素影响健康的规律与特点	12
3.3 将健康融入所有政策的理念与实践	12
3.4 复习题	12
第四章 社会经济因素与健康	14
4.1 基本内涵及衡量指标	14
4.1.1 经济发展的衡量指标	14
4.1.2 健康的衡量指标	14
4.2 经济发展与健康	14
4.3 经济发展与健康投资	15
4.4 复习题	15
第五章 社会环境因素与健康	16
5.1 人口与健康	16
5.1.1 人口数量与健康	16
5.1.2 人口结构与健康（难点*）	16
5.2 生活工作环境与健康	17
5.2.1 体力活动与健康	17
5.2.2 城市化与健康	17
5.3 社会网络与健康	17
5.3.1 社会网络、人际关系与社会支持	17
5.3.2 家庭与健康	17
5.3.3 社会阶层与健康	18
5.4 复习题	18

第六章 社会文化因素与健康	19
6.1 文化的概念、构成及特征	19
6.2 文化影响健康的模式与特点	19
6.3 文化诸现象对健康的影响	19
6.3.1 教育对健康的影响	20
6.3.2 科技进步与健康	20
6.3.3 风俗习惯与健康	20
6.3.4 宗教与健康	20
6.4 复习题	20
第七章 行为心理因素与健康	22
7.1 心理因素与健康	22
7.1.1 人格与健康	22
7.1.2 心理压力与健康	22
7.2 行为生活方式与健康	23
7.3 行为心理问题的干预	23
7.4 常见健康相关行为——吸烟与控烟	23
7.5 复习题	23
第八章 社会医学研究方法	25
8.1 社会医学研究方法概述	25
8.1.1 相关研究方法	25
8.1.2 社会医学研究的步骤	25
8.1.3 非概率抽样方法	25
8.2 定量研究	25
8.3 问卷设计	26
8.4 信度与效度（难点*）	26
8.5 定性研究	27
8.6 复习题	27
第九章 卫生服务研究	29
9.1 卫生服务研究概述	29
9.2 卫生服务需要、需求与利用（难点*）	29
9.3 卫生资源	30
9.4 卫生服务综合评价（难点*）	30
9.5 复习题	30
第十章 健康危险因素评价	31
11.1 健康危险因素概述	31
11.2 健康危险因素评价	31
11.3 复习题	31
第十二章 生命质量评价	33
12.1 生命质量的概念与构成	33
12.2 生命质量的评价方法（难点*）	33
12.3 生命质量评价的应用	33
12.4 复习题	34
第十三章 社会卫生状况	35
13.1 社会卫生状况概述	35
13.2 人群健康状况的评价指标（难点*）	35
13.2.1 单一型指标	35
13.2.2 复合型指标（难点*）	35
13.2.3 健康影响因素指标（难点*）	36
13.3 健康中国与健康中国2030	36
13.3.1 健康中国2030	36
13.3.2 21世纪人人享有卫生保健	36
13.3.3 初级卫生保健	36
13.3.4 千年发展目标（MDGs）与可持续发展目标（SDGs）	36

13.4 复习题	36
第十四章 健康管理与治理	38
16.1 健康管理	38
16.1.1 健康管理的概念和内涵	38
16.1.2 以社区为基础的健康管理与治理	38
16.2 健康治理	38
16.3 各层面的健康管理与治理	39
16.4 复习题	39
第十七章 社区卫生服务	40
17.1 社区与社区卫生服务概述	40
17.1.1 社区	40
17.1.2 社区卫生服务	40
17.1.3 社区卫生服务的意义	41
17.2 社区卫生服务的管理（难点*）	41
17.3 复习题	41
第十八章 社会病防治	42
21.1 社会病概述	42
21.2 自杀行为	42
21.2.1 自杀的概念与分类	42
21.2.2 自杀的发生率与分布	43
21.2.3 自杀的社会根源	43
21.2.4 自杀的预防	43
21.3 其他社会病	43
21.3.1 成瘾行为	43
21.3.2 攻击与暴力	44
21.4 复习题	44

- 本复习笔记严格依照《社会医学（ ）》教学大纲（2026 版）章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 各章末附有复习题（选择题、填空题、名词解释、简答题），题目主要来源于教学平台题库及大纲重点内容。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- 大纲中**句尾”*”** 标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的标红内容重点复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾”*” = 教学难点

本章导览：掌握社会医学的概念、研究对象和研究内容；熟悉社会医学的任务、特色理论与创新观点；了解社会医学的发展历程（国内外）；掌握三次卫生革命的主要特征。

1.1 社会医学的概念、内容与任务

1.1.1 社会医学的概念

[概念] 概念释义：社会医学（**Social Medicine**）：是研究社会因素与健康及疾病之间相互联系及其规律的一门学科，是医学与社会科学的交叉学科。

社会医学从社会的角度研究医学与健康问题。研究社会因素与个体及群体健康和疾病之间相互作用及其规律，制订相应的社会措施，保护和增进人群的身心健康和社会活动能力，提高生命质量，充分发挥健康的社会功能，提高人群的健康水平。

知识基础主要来源：医学科学、社会科学。

双重属性：自然科学、社会科学。

1.1.2 研究对象与内容

！重点掌握：（一）研究对象

人群，特别是高危人群（处于高危状态下的人群，如老人、儿童、妇女、残疾者、有害作业职工、流动人口等）。

（二）研究内容

1. **社会卫生状况，主要是人群健康状况**——寻找主要的社会卫生问题；发现高危人群及弱势人群；确定防治工作重点。→ **作社会医学诊断**
2. **影响健康的诸因素，重点是社会因素**——分析社会因素对健康产生的积极和消极作用。→ **作社会病因分析**
3. **社会卫生策略与措施**——涵盖卫生发展的一系列战略与策略、目标与指标、政策与措施等。包括合理配置卫生资源、科学组织常规卫生服务和应对突发公共卫生事件的应急机制、为改善卫生服务公平和效率而采取的一系列政治、经济、法律和文化教育等方面的综合性策略与措施。→ **开社会医学处方**

（三）研究对象和内容的相对性

社会医学的具体研究对象和内容因社会经济发展状况和各国的具体情况不同而有所区别。

1.1.3 三次卫生革命

！重点掌握：第一阶段（第一次卫生革命，19 世纪 ~20 世纪中叶）

- 主要社会卫生问题：传染病流行，社会卫生状况不良，人群健康状况差
- 主要斗争目标：传染病、寄生虫病和地方病
- 主要策略：制订国家卫生措施和环境卫生工程措施，预防接种、抗菌药物、杀菌灭虫，基本卫生条件的改善

第二阶段（第二次卫生革命，约 20 世纪中叶起）

- 主要社会卫生问题：慢性非传染性疾病增多，高新医疗技术广泛应用，卫生费用剧增，健康不公平性日益突出
- 主要斗争目标：慢性非传染性疾病

- 主要策略：三级预防，提倡健康行为生活方式，改变不良行为生活方式，降低危险因素，早期发现、早期诊断、早期治疗

第三阶段（第三次卫生革命，约 20 世纪下半叶起）

- 主要社会卫生问题：健康不公平性
- 主要斗争目标：提高生命质量、促进全人类健康长寿，实现 WHO 倡导的“人人享有卫生保健”
- 主要策略：与贫困作斗争，在所有环境中促进健康，部门间的协调、协商和互利，实现卫生系统可持续发展等

1.1.4 社会医学的任务

[概念] 概念释义：（一）社会医学的基本任务：(1) 掌握社会卫生状况及人群健康状况；(2) 发现主要的社会卫生问题及其影响因素；(3) 提出改善社会卫生状况即促进人群健康状况的策略和措施；(4) 确定卫生工作重点，合理配置卫生资源，科学组织卫生服务，加强卫生监督和评价。

（二）我国社会医学的基本任务：(1) 倡导积极的健康观和现代医学模式，强调健康的社会决定因素；(2) 改善社会卫生状况，提高人群健康水平；(3) 制订社会卫生策略和措施；(4) 开展健康弱势群体保健和社会病控制。

1.2 社会医学的发展

1.2.1 萌芽与西方发展

[概念] 概念释义：萌芽时期：古希腊希波克拉底、古罗马盖伦、阿拉伯阿维森纳、意大利拉马兹尼。德国卫生学家提出《全国医学监督体制》，主张用医学监督计划使政府采取措施来保护个人和公众健康。

西方国家创立与发展：

- 1838 年法国罗舒（J.A. Rochoux）首先提出“社会卫生学”专用名词
- 1848 年法国儒勒·盖林第一次提出“社会医学”概念，分四部分：社会生理学、社会病理学、社会卫生学、社会治疗学
- 德国——社会医学的发源地：诺尔曼（Neumannn）、魏尔啸（Virchow）——“医学科学的核心是社会科学”、“医学是一门社会科学，任何社会都应对居民的健康负责”；格罗蒂扬（Grotjahn）——《社会病理学》，1920 年在柏林大学开设社会卫生学课程

1.2.2 我国社会医学的发展

[概念] 概念释义：20 世纪 30 年代陈志潜——河北定县社区保健试验基地、南京晓庄乡村卫生实验区、“三级医疗卫生保健网组织”。1949 年中国医科大学建立公共卫生学院，设立卫生行政学科。1952 年引入前苏联《保健组织学》。1980 年卫生部《关于加强社会医学与卫生事业管理教学研究工作的意见》。目前全国百余所院校开设社会医学课程。

1.3 社会医学的特色理论与创新观点

！重点掌握：一、卫生事业与社会协调发展——卫生事业以社会发展（尤其是国民经济）为基础，其规模与速度直接受社会发展制约；卫生事业发展是社会发展组成，为社会发展提供保障。

二、健康与社会经济发展的双向作用——社会经济发展对人群健康水平提高的基础性作用；人群健康水平的提高对社会经济发展的促进作用。

三、生理、心理、社会的健康观——生物学角度：检查器官功能和各项指标是否正常；心理学角度：有无自我控制能力、能否正确对待外界影响、是否处于内心平衡状态；社会学角度：社会适应性、良好的工作和生活习惯、人际关系和应付突发事件的能力。

四、高危人群和高危因素——WHO 高危险性分析：以高危险性观点找出卫生工作主要问题，采取重点防治措施。高危人群：容易受疾病侵扰的人群；高危环境：存在危险因素的自然、社会和心理环境；高危因素：对健康构成威胁的因素如吸烟、酗酒、吸毒等。

五、疾病防治中社会因素的决定作用——慢性非传染性疾病中社会因素的决定性作用；传染性疾病防治依赖社会防治措施（UNICEF 提出技术突破和社会突破，后者为决定性）。

六、全社会参与的大卫生观——卫生事业本质上是一种“人人需要、共同受益”的社会公益事业，实现健康需要全社会、各部门、各领域的积极行动和协同推进，促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程。

1.4 复习题

1. 【名词解释】社会医学；社会诊断；社会病因分析；社会医学处方
2. 【名词解释】高危人群；高危环境；高危因素
3. 【简答题】简述社会医学的概念、研究对象和三大研究内容。
4. 【简答题】试述三次卫生革命的主要特征。
5. 【简答题】简述社会医学的六大特色理论与创新观点。

参考答案要点

1. **社会医学**：研究社会因素与健康及疾病之间相互联系及其规律的一门学科，是医学与社会科学的交叉学科，具有自然科学和社会科学双重属性。三大内容：社会卫生状况/人群健康状况 → 社会诊断；影响健康的社会因素 → 社会病因分析；社会卫生策略与措施 → 社会医学处方。
2. **高危人群**：容易受疾病侵扰的人群，包括处于高危险环境的人群、对环境有高危反应的人群及有高危行为的人群。**高危环境**：存在危险因素的自然、社会和心理环境。**高危因素**：对健康构成威胁的因素。
3. 见第 1 题。
4. 第一次：传染病/寄生虫病/地方病 → 国家卫生措施 + 环境卫生 + 预防接种 + 抗菌药物。第二次：慢性非传染病增多 + 费用剧增 + 健康不公平 → 三级预防 + 健康生活方式 + 三早。第三次：健康不公平性 → 提高生命质量 + 人人享有卫生保健 + 与贫困斗争 + 部门协调 + 卫生系统可持续发展。
5. (1) 卫生事业与社会协调发展；(2) 健康与社会经济发展的双向作用；(3) 生理、心理、社会的健康观；(4) 高危人群和高危因素；(5) 疾病防治中社会因素的决定作用；(6) 全社会参与的大卫生观。

本章导览：掌握医学模式的概念；掌握生物-心理-社会医学模式的概念和基本内涵（难点*）；掌握综合健康医学模式（Lalonde-Dever 模式）；掌握 WHO 的健康观（积极健康观）；熟悉医学模式的演变过程（神灵主义 → 自然哲学 → 机械论 → 生物医学 → 生物-心理-社会）；熟悉生物医学模式的基本观点和意义；了解生物-心理-社会医学模式产生的四大背景和对医学实践的影响（“四个扩大”）。

2.1 医学模式的概念

[概念] 概念释义：模式（Model）：指从事物中抽象出某些特征，构成关于某种事物的标准形式，对人们观察、思考和解决问题起着指导作用。即人们认识和解决问题的思想和行为方式。

医学模式（Medical Model）：人类在与疾病抗争和认识自身生命过程的实践中得出的对健康观和疾病观等重要医学观念的本质概括。包括：医学的总体结构特征；指导医学实践的基本观点；体现以医学为对象的自然观和方法论。

2.2 医学模式的演变

！重点掌握：神灵主义医学模式 → 自然哲学医学模式（经验医学时期） → 机械论医学模式（近代医学时期） → 生物医学模式（现代医学时期） → 生物-心理-社会医学模式

生物医学模式（约 1800~1970 年）：

- **背景：**社会生产力发展，科学技术水平提高；能量守恒和转化定律、细胞学说、生物进化论三大发现；疾病的细菌学病因理论
- **含义：**从生物学角度认识健康与疾病，反映病因、宿主和自然环境三者内在联系的医学观和方法论
- **基本观点：**模式建立在生物科学基础上；流行病学三角模式（生态学模式）——健康是宿主、环境和病因三者之间的平衡，疾病则是该平衡的破坏；机体组织结构的变化和生理生化功能的异常导致疾病发生；病因多系生物的、理化的，单因单果的疾病表现形式；没有病即是健康
- **意义：**诊断（细胞病理学）、治疗（疼痛、感染和失血）、预防（杀菌灭虫、预防接种、抗菌药物）
- **不足：**强调人的生物属性，没有认识到人的社会属性；重视机体生理活动，忽视心理活动

2.3 生物-心理-社会医学模式与健康观

2.3.1 产生背景

！重点掌握：1. **疾病谱和死因谱的改变**——生物医学模式使传染病防治技术取得重大突破，全球疾病和死因结构发生了显著改变，影响人群健康的主要疾病已由传染病转变为慢性非传染性疾病。

2. **健康需求的提高**——随着生产力发展和生活水平提高，人们的健康需求日益多样化，不再仅仅满足于疾病的防治，而是积极地提高健康生活的品质。这就要求医疗卫生工作必须应对多样化的健康需求，全面满足人们生理、心理和社会的健康需求。

3. **医学社会化**——医学是社会性的事业，承担着社会保健职能。随着城市化发展，生产和生活消费行为进一步社会化，公共卫生和社会保健问题日益突出。许多健康问题无法依靠传统的医疗卫生技术予以解决，必须采取社会化的措施才能找到解决方案。整个社会系统都承担着保健职能。

4. 医学学科的内部融合与外部交叉发展——在对人的疾病、健康开展微观研究的同时，必须考虑人的完整性，考虑人具有的心理属性；人的社会性决定影响人群健康因素的多样性及社会性；医学的社会化导致解决健康问题需要全社会参与。

2.3.2 生物-心理-社会医学模式的内涵（难点*）

！重点掌握：含义：指从生物、心理、社会等方面来观察、分析、思考以及处理健康与疾病相关问题的医学观和方法论。

几种生物-心理-社会医学模式：

- **恩格尔（Engel）的医学模式：**从 Person→Family→Community→Society/Nation 多层次系统理解健康
- **布鲁姆（Blum）的环境健康医学模式：**Health 受 Physiology、Medical Service、Psychology、Society、Behavior factors 综合影响
- **综合健康医学模式（Lalonde-Dever 模式）：**由拉隆达（Lalonde）和德威尔（Dever）在布鲁姆模式基础上提出，将影响人类健康及疾病的主要因素分为**环境因素、行为生活方式、生物遗传、卫生服务**四大类，每一大类又包括三小类。认为不同的疾病四大类影响因素作用不同。

基本内涵：

1. 强调了心理、社会因素在医学研究系统中应有的位置
2. 更加准确肯定了生物因素的含义和生物医学的价值
3. 全方位探求影响人类健康与疾病的因果关系——健康问题是医学问题也是社会问题

对医学实践的影响——“四个扩大”：

1. 从治疗服务扩大到预防保健服务
2. 从生理服务扩大到心理服务
3. 从院内服务扩大到院外服务
4. 从技术服务扩大到社会服务

2.3.3 健康观

！重点掌握：（一）消极健康观（传统健康观）

“无病就是健康”是传统健康观的核心。特征：（1）单一性；（2）以二元形式来记录健康（疾病或死亡的有或无）；（3）健康与否由医生作出判断。

（二）积极健康观（WHO 整体健康观）

WHO 指出：“健康而且是一种躯体上、心理上和社会适应方面的完好状态，不仅仅是没有疾病和虚弱现象。”（Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity.）

积极健康的内容：

1. **躯体健康：**躯体的结构完好和功能正常
2. **心理健康：**正确认识自我、正确认识环境、及时适应环境
3. **社会适应能力良好：**每个人的能力应在社会系统内得到充分的发挥；作为健康人应有效地扮演与其身份相适应的角色；每个人的行为与社会规范相一致

积极健康观的特征：

1. **健康具有多维性：**包括身体健康、心理健康、社会健康、角色功能和健康感觉。疾病（disease，生物尺度）、病患（illness，感觉尺度）、患病（sickness，行动尺度）
2. **健康具有连续性：**健康谱——从完全健康到最差的健康状态或死亡是个连续变化的谱级。亚健康状态：虽无明显的疾病，但呈现活力降低、适应力不同程度减退的生理状态。亚临床状态：没有临床症状体征，但存在生理性代偿或病理性改变的临床检测证据
3. **健康描述的功能性：**着重于处于某种健康状态下的个人其行为能力如何，即用行为或功能术语表述健康

健康概念的扩展：从个体健康扩大到群体健康，以及人类生存空间的完美。如健康社区、健康城市、健康国家（如健康中国 2030）。树立“人人为健康，健康为人人”的正确概念，把健康问题看作是全社会、全民的事业。

2.4 复习题

1. 【名词解释】医学模式；生物医学模式；生物-心理-社会医学模式；综合健康医学模式
2. 【名词解释】消极健康观；积极健康观；亚健康状态；亚临床状态
3. 【简答题】简述医学模式演变的五个阶段。
4. 【简答题】简述生物医学模式的基本观点及其不足。
5. 【简答题】试述生物-心理-社会医学模式产生的四大背景。
6. 【简答题】简述生物-心理-社会医学模式的基本内涵及“四个扩大”。
7. 【简答题】简述综合健康医学模式（Lalonde-Dever 模式）的主要内容。
8. 【简答题】试述 WHO 积极健康观的内容和特征。

参考答案要点

1. **医学模式**：人类在与疾病抗争和认识自身生命过程的实践中得出的对健康观和疾病观等重要医学观念的本质概括。**生物医学模式**：从生物学角度认识健康与疾病，反映病因、宿主和自然环境三者内在联系的医学观和方法论。**生物-心理-社会医学模式**：从生物、心理、社会等方面来观察分析和处理健康与疾病相关问题的医学观和方法论。**综合健康医学模式（Lalonde-Dever）**：将影响健康的因素分为环境因素、行为生活方式、生物遗传、卫生服务四大类。
2. **消极健康观**：“无病就是健康”，特征为单一性、二元形式、医生判断。**积极健康观**：WHO 定义——躯体上、心理上和社会适应方面的完好状态，不仅仅是没有疾病和虚弱。**亚健康**：虽无明显疾病但活力降低、适应力减退的生理状态。**亚临床**：无临床症状体征但存在生理性代偿或病理性改变的检测证据。
3. 神灵主义医学模式 → 自然哲学医学模式（经验医学）→ 机械论医学模式（近代医学）→ 生物医学模式（现代医学约 1800-1970）→ 生物-心理-社会医学模式。
4. 基本观点：建立在生物科学基础上；流行病学三角模式（健康是宿主-环境-病因平衡）；组织结构改变和生理生化异常导致疾病；病因多系生理理化单因单果；无病即健康。不足：强调生物属性忽视社会属性；重视生理活动忽视心理活动。
5. (1) 疾病谱和死因谱改变（传染病 → 慢性非传染病）；(2) 健康需求提高（多样化、品质化）；(3) 医学社会化（公共卫生问题突出、需社会化措施）；(4) 医学学科内部融合与外部交叉发展（需考虑人的完整性和心理属性）。
6. 基本内涵：(1) 强调心理社会因素应有位置；(2) 更准确肯定生物因素含义和生物医学价值；(3) 全方位探求影响健康的因果关系。四个扩大：治疗 → 预防保健、生理 → 心理、院内 → 院外、技术 → 社会。
7. 由 Lalonde 和 Dever 在 Blum 环境健康医学模式基础上提出，将影响健康的因素分为四大类：环境因素、行为生活方式、生物遗传、卫生服务，每大类又包括三小类。不同疾病四大类因素作用不同。
8. 内容：躯体健康（结构完好功能正常）+ 心理健康（正确认识自我/环境/及时适应）+ 社会适应良好（能力发挥 + 角色扮演 + 行为规范一致）。特征：(1) 多维性（身体健康 + 心理健康 + 社会健康 + 角色功能 + 健康感觉，disease/illness/sickness 三维度）；(2) 连续性（健康谱、亚健康和亚临床状态）；(3) 功能性（用行为或功能术语表述健康）。

本章导览：掌握健康社会决定因素的概念（难点*）；掌握健康社会决定因素的理论模型（达尔格伦和怀特海德模型）和行动框架；熟悉社会因素的概念和影响健康的规律与特点（非特异性/泛影响性、恒常性/积累性、交互作用）；熟悉将健康融入所有政策（HiAP）的理念与实践；了解健康社会决定因素理论的发展历程和价值理念（健康公平）。

3.1 健康社会决定因素概述

3.1.1 基本概念

[概念] 概念释义：社会因素（**Social Factor**）：指社会的各项构成要素，包括一系列与社会生产力和生产关系有密切联系的因素，即以生产力发展水平为基础的经济状况、社会保障、环境、人口、教育以及科学技术，和以生产关系为基础的社会制度、法律体系、社会关系、卫生保健以及社会文明等。

健康社会决定因素（Social Determinants of Health, SDH）：WHO 定义——在那些直接导致疾病的因素之外，由人们的社会地位和所拥有资源所决定的生活和工作的环境及其他对健康产生影响的因素。健康社会决定因素被认为是决定人们健康和疾病的根本原因，包括了人们从出生、成长、生活、工作到衰老的全部社会环境特征，例如收入、教育、饮水和卫生设施、居住条件、社会区隔等，它也反映了人们在社会结构中的阶层、权力和财富的不同地位。

核心价值理念：健康公平——“健康是一项基本人权，不因种族、宗教、政治信仰、经济或者社会情境不同而有差异”。**健康公平性：**不同社会人群具有相同的健康状况或健康差别尽可能缩小，或者不同人群具有相同的获得健康的机会。

3.1.2 理论发展历程

[概念] 概念释义：

- 世界卫生组织的成立
- 以社区为基础的预防保健模式兴起
- 《阿拉木图宣言》和初级卫生保健
- 20 世纪 80 年代《渥太华宪章》
- 2003 年 WHO 成立宏观经济与卫生委员会
- **2005 年 WHO 设立健康社会决定因素委员会（CSDH）**，2009 年发布《用一代人时间弥合差距》报告——阐明不同地域和人群健康差异的根本性原因是社会不公
- 2011 年《里约政治宣言》——呼吁采取健康问题社会决定因素方针减少健康不公平，5 个重点行动领域

3.2 健康社会决定因素的框架与内容

3.2.1 理论模型与行动框架

！重点掌握：健康社会决定因素模型（达尔格伦和怀特海德，**Dahlgren & Whitehead**）：

从内到外层次：年龄/性别/遗传因素 → 个体生活方式 → 社会支持网络 → 社会经济地位 → 工作环境/城市化/卫生保健服务等 → 宏观社会经济、文化和环境。

健康社会决定因素的行动框架（WHO CSDH）：

社会经济和政治背景（政治治理、宏观经济、社会政策、福利资源分配、文化/社会规范和价值观）→ 社会地位（教育、职业、收入、性别、种族/民族）→ 物质环境、社会支持网络、社会心理因素、行为、生物遗传因素 → 卫生保健系统 → 影响健康的社会因素和健康不平等。

社会决定因素影响健康和健康公平的路径：社会结构性因素决定着人们的日常生活环境，而国家和政府所采取的不同社会资源分配制度（包括卫生体系和其他社会福利制度）可以影响社会结构性因素和日常生活环境。

WHO 基于健康社会决定因素的政策建议：

1. 改善人们的日常生活环境（改善女童和妇女生活环境、儿童出生环境、重视幼儿期成长教育、改善生活工作环境、制定社会保护政策、关注老年人）
2. 关注形成日常生活环境的社会结构性因素，解决权力、财富和社会资源分配不公平问题
3. 注重测量和收集证据，评估行动效果，提高公众对健康社会决定因素的认识

3.2.2 社会因素影响健康的规律与特点

！重点掌握：1. 非特异性和泛影响性

- 非特异性：疾病是由多种因素综合决定，一种疾病很难用某种单一的特定社会因素来完全解释
- 泛影响性（作用的发散性）：指一种社会因素可导致全身多个器官及系统发生功能性变化

2. 恒常性和积累性

- 恒常性：社会因素相对稳定，影响无形、缓慢和持久（时间/作用过程）
- 积累性：社会因素以一定的时序作用于人体，可形成应答累加、功能损害累加和健康效应累加（时间/效应）

3. 交互作用（多因多果/多因单果）

交互作用：一种社会因素可以直接影响人群健康，也可以作为其他社会因素的中介，或以其他社会因素为中介作用于健康。

3.3 将健康融入所有政策的理念与实践

[概念] 概念释义：WHO 从健康社会决定因素方面改善健康公平，**关键策略：将健康融入所有政策（Health in All Policies, HiAP）。**

产生和发展：2006 年芬兰卫生部门明确提出并发展了 HiAP 概念；2013 年第八届全球健康促进大会通过《赫尔辛基宣言：将健康融入所有政策》和《实施“将健康融入所有政策”的国家行动框架》。

基本理念：一种以改善人群健康和健康公平为目标的公共政策制定方法，它系统地考虑这些公共政策（包括财政、教育、科技、就业、社会保障、环境保护、医药管理等）可能带来的健康后果，寻求部门间协调，避免政策对健康造成不利影响。

2014 年 WHO《将健康融入所有政策国家行动框架》6 项行动任务：确定需求和优先领域 → 制定行动计划 → 确认支持性的组织机构和程序 → 促进评估和参与 → 确保监测、评价和报告 → 加强能力。

3.4 复习题

1. 【名词解释】社会因素；健康社会决定因素（SDH）；健康公平
2. 【名词解释】HiAP（将健康融入所有政策）
3. 【简答题】简述健康社会决定因素的理论模型（达尔格伦和怀特海德）。
4. 【简答题】简述 WHO CSDH 行动框架的主要内容和政策建议。
5. 【简答题】试述社会因素影响健康的规律与特点。
6. 【简答题】简述将健康融入所有政策（HiAP）的基本理念和行动框架。

参考答案要点

1. **社会因素：**社会的各项构成要素，包括与生产力发展水平为基础的经济状况等和以生产关系为基础的社会制度等。**SDH：**WHO 定义——在直接导致疾病的因素之外，由人们社会地位和所拥有资源决定的生活工

作环境及其他对健康产生影响的因素，是决定人们健康和疾病的根本原因。**健康公平**：不同社会人群具有相同的健康状况或健康差别尽可能缩小，具有相同的获得健康的机会。

2. **HiAP**：一种以改善人群健康和健康公平为目标的公共政策制定方法，系统地考虑公共政策可能带来的健康后果，寻求部门间协调，避免政策对健康造成不利影响。
3. 从内到外层次：年龄/性别/遗传因素 → 个体生活方式 → 社会支持网络 → 社会经济地位 → 工作环境/城市化/卫生保健服务 → 宏观社会经济/文化/环境。
4. 行动框架：社会经济和政治背景 → 社会地位（教育/职业/收入/性别/种族）→ 物质环境 + 社会支持 + 心理因素 + 行为 + 生物遗传 → 卫生保健系统 → 健康不平等。三大政策建议：(1) 改善日常生活环境；(2) 解决权力/财富/资源分配不公平；(3) 测量收集证据、评估效果、提高公众认识。
5. (1) 非特异性和泛影响性——非特异性（多因素综合决定，单一社会因素不能完全解释疾病）+ 泛影响性（一种社会因素可导致全身多器官系统功能性变化）；(2) 恒常性和积累性——恒常性（影响无形缓慢持久）+ 积累性（应答累加/功能损害累加/健康效应累加）；(3) 交互作用——一种社会因素可直接或作为其他因素的中介影响健康。
6. 见第 2 题。6 项行动任务：(1) 确定需求和优先领域 → (2) 制定行动计划 → (3) 确认支持性组织机构和程序 → (4) 促进评估和参与 → (5) 确保监测评价和报告 → (6) 加强能力。

本章导览：掌握经济发展水平与健康的双向作用（难点*）；熟悉经济发展的衡量指标（GDP/GNP/HDI等）和健康的衡量指标；熟悉健康投资的内涵；了解经济发展与卫生服务的关系。

4.1 基本内涵及衡量指标

4.1.1 经济发展的衡量指标

[概念] 概念释义：经济是指一个国家国民经济的总称。经济发展（Economic Development）是人类不断改善生产生活质量、逐步摆脱贫困落后状态、持续提高社会经济福利的过程，其终极目标落脚于人们幸福生活的最终实现。

传统指标：GDP（国内生产总值）、GNP（国民生产总值）、人均 GDP、人均 GNP、卫生总费用（Total Health Expenditure, THE）、人均卫生总费用。

新的衡量指标（关注可持续性发展）：人类发展指数（HDI）、真实发展指标（GPI）、国民幸福指数（NHI）、全球幸福指数（GHI）、物质生活质量指数（PQLI）。

4.1.2 健康的衡量指标

[概念] 概念释义：人群健康状况指标：期望寿命（Expectancy life）、婴儿死亡率（Infant mortality rate）、孕产妇死亡率（Maternal mortality rate）、发病率（incidence rate）、患病率（prevalence rate）、健康期望寿命（Healthy life expectancy）、伤残调整生命年（DALYs）。

4.2 经济发展与健康

！重点掌握：经济发展与健康的双向性作用关系：健康水平的提高 经济发展 带来健康新问题。

一、经济发展对健康的促进作用及途径

1. 经济发展提高了居民物质生活水平，提供了保障人群健康的生活条件
2. 经济发展有利于增加健康投资
3. 经济发展可通过影响其它途径（如教育）促进人群健康

二、经济发展对健康促进作用的有限性

经济增长与健康水平之间并不存在必然联系。当经济发展到一定水平，影响健康的不再是经济的绝对水平，而是社会经济的公平性。Wilkinson 指出：在发达国家，健康水平最高的不是那些最富有的国家，而是那些最具有社会公平性的国家。

三、经济发展带来的新问题

1. 环境的污染和生态破坏（公害病、已有疾病加重、常见病更为频发）
2. 生活方式改变（营养、身体活动）
3. **现代社会病的产生**——随着现代科技高速发展，由新的生活方式所带来的一系列疾病和社会现象，如“富贵病”和“文明病”（肥胖、高血压、糖尿病、性病、车祸、吸毒、新的成瘾性疾病等）
4. 心理健康问题的凸显——社会竞争加剧、生存压力加大、导致心身疾病、严重者可致精神病甚至自杀和报复性他杀
5. 负性社会事件增多
6. 社会人口特征剧烈变化（老龄化、社会流动人口增加 → 疾病传播 + 卫生服务提供）

四、健康对经济发展的作用

1. 增加劳动力供给（平均寿命延长）
2. 提高劳动生产率（劳动效率提高、伤病减少、出勤增加）
3. 减少疾病损失，减少资源消耗
4. 促进教育受益实现
5. 促进自然资源利用

4.3 经济发展与健康投资

[概念] 概念释义：健康投资（Health Investment）：指人们为了获得良好的健康而消费的食品、闲暇时间和卫生服务的资源。WHO 提出投资于健康的理念（宏观经济与卫生）。

目的：维持或提高现有健康存量（耐久资本）。健康存量增加：吸收营养、接受卫生服务、运动锻炼、教育等（健康投资）。健康存量减少：疾病、营养不良、衰老、劳损等（折旧）。

意义：减轻潜在疾病的经济负担；改善人群的健康水平；促进经济发展、社会进步和国家安全。

投资主体：私人健康人力资本投资（家庭营养保健支出、医疗私人支出、居住环境改善、休息等）+ 公共健康人力资本投资（医疗卫生设施建设、公共卫生环境建设、医疗工作者薪酬支付、居民医疗补贴等）。

健康投资效益：两个效益——经济效益和社会效益；两个层面——微观和宏观。经济效益：个体/家庭收入水平增加和宏观经济增长。社会效益：个体幸福感提高和社会和谐稳定。

4.4 复习题

1. 【名词解释】经济发展；GDP；卫生总费用；健康投资；HDI
2. 【简答题】试述经济发展与健康的双向性作用关系。
3. 【简答题】简述经济发展给健康带来的新问题。
4. 【简答题】简述健康对经济发展的促进作用。
5. 【简答题】简述健康投资的内涵和意义。

参考答案要点

1. **经济发展：**人类不断改善生产生活质量、逐步摆脱贫困落后状态、持续提高社会经济福利的过程。**GDP：**一个国家或地区范围内所有常住单位在一定时期内生产最终产品和提供劳务价值的总和。**卫生总费用：**在一定时期内为提供卫生服务所消耗的经济资源。**健康投资：**人们为了获得良好健康而消费的食品、闲暇时间和卫生服务的资源。**HDI：**人类发展指数，新型经济发展衡量指标。
2. **双向作用：**(1) 经济发展对健康的促进作用（提高生活水平、增加健康投资、通过教育等途径促进健康）；(2) 健康对经济的促进作用（增加劳动力供给、提高劳动生产率、减少疾病损失和资源消耗、促进教育受益和自然资源利用）。有限性：经济增长与健康水平不存在必然联系，影响健康的是社会经济公平性。
3. (1) 环境的污染和生态破坏；(2) 生活方式改变；(3) 现代社会病的产生——“富贵病”“文明病”（肥胖、高血压、糖尿病等）；(4) 心理健康问题凸显（竞争加剧、心身疾病）；(5) 负性社会事件增多；(6) 社会人口特征剧烈变化（老龄化、流动人口增加）。
4. (1) 增加劳动力供给（平均寿命延长）；(2) 提高劳动生产率（效率提高 + 伤病减少 + 出勤增加）；(3) 减少疾病损失，减少资源消耗；(4) 促进教育受益实现；(5) 促进自然资源利用。
5. **内涵：**为了获得良好健康而消费的食品、闲暇时间和卫生服务的资源，目的是维持或提高健康存量。**意义：**减轻潜在疾病经济负担、改善人群健康水平、促进经济发展/社会进步/国家安全。投资主体包括私人 and 公共健康人力资本投资。**效益：**经济效益（个体收入 + 宏观增长）+ 社会效益（幸福感 + 社会和谐）。

本章导览：掌握人口结构与健康（性别构成、年龄构成、负担系数、人口金字塔）；掌握社会支持的概念及类型；掌握家庭的类型（核心家庭、主干家庭、联合家庭）与功能（APGAR 问卷）；熟悉人口数量/素质/流动与健康；熟悉体力活动与健康（含静态行为）；熟悉城市化与健康的正负向影响；熟悉社会网络的内涵与作用；熟悉社会阶层的概念及其对健康的影响。

5.1 人口与健康

5.1.1 人口数量与健康

[概念] 概念释义：人口数量是指在一定时点和地理范围内，人口的绝对量和相对量。人口数量一定要以社会经济及卫生事业的发展为依据。

常用指标：静态——时点人口数、时期人口数、人口密度；动态——出生率、死亡率、人口自然增长。

人口增长过快/过多 → 加重社会负担/影响生活质量、加重教育及卫生事业负担/影响人口素质、加重环境污染和破坏。人口增长过慢（负增长）→ 经济发展减缓、加重社会老年人口抚养负担。

5.1.2 人口结构与健康（难点*）

！重点掌握：（一）人口性别构成

性别百分比：**人口性比例 = 男性人口数/女性人口数 × 100**。性比例大于 100 说明男性多于女性，小于 100 说明女性多于男性。一般国家出生时性比例为 103~107。性别比例失调的影响：影响人口再生产、影响社会稳定、影响农村社会经济发展。

（二）人口年龄构成

- **老年人口系数** = 老年人口数/总人口数 × 100%
- **儿童少年人口系数** = 儿童少年人口数/总人口数 × 100%
- 老年型社会：60 岁及以上人口超过 10% 或 65 岁及以上超过 7%

负担系数：指非劳动力人口数与劳动力人口数的比值。

- **总负担系数** = (14 岁及以下 + 65 岁及以上) / 15~64 岁 × 100%
- **老年负担系数** = 65 岁及以上 / 15~64 岁 × 100%
- **少年儿童负担系数** = 14 岁及以下 / 15~64 岁 × 100%

人口金字塔三种类型：

- **增长型：**塔型基底宽顶尖，年轻人比重大
- **稳定型：**塔底和塔身宽度基本接近，塔尖逐渐收缩
- **缩减型：**塔底窄，塔身宽，年轻人少中年人比例大

（三）人口素质

人口素质是身体素质、文化素质和思想道德素质的综合体现。身体素质：用健康状况、体力和精力状况、生命力和寿命来反映。人口素质评价可用物质生活质量指数（PQLI）和美国社会健康协会指标（ASHA）来表示。

（四）人口流动

人口流动是指人口在地理空间位置上的变动和阶层职业上的变动。人口流动可促进经济繁荣和社会发展，但如果过多或过速，会产生负面作用（增大城市人口拥挤、带入疾病、引起传染病暴发流行）。高危人群：儿童、老年人和孕产妇。

5.2 生活工作环境与健康

5.2.1 体力活动与健康

[概念] 概念释义：体力活动（Physical Activity）/ 身体活动：指通过人体肌肉骨骼活动而产生能量消耗的各种活动。

分类：按能量供应途径（有氧运动/无氧运动）；按日常生活安排（职业性/交通行程性/家务性/闲暇时间运动锻炼）；按生理功能（有氧运动/抗阻力活动/关节柔韧性活动/身体平衡和协调性练习）。

静态行为（Sedentary Behavior）：指人一天坐着较长时间的行为，包括工作、学习和休闲所坐的时间。清醒时坐或倚靠着代谢当量（METs）1.5 kcal/kg·h 的行为。

缺乏规律的体力活动是众多慢性疾病的主要危险因素之一。WHO《2002 年世界卫生报告》指出体力活动不足或静坐方式是全世界引起死亡和残疾的前 10 项原因之一。

WHO 成人（18~64 岁）体力活动建议：每周至少 150 分钟中等强度或 75 分钟高强度有氧身体活动；有氧活动每次至少持续 10 分钟；每周至少 2 天大肌群参与的强壮肌肉活动。

5.2.2 城市化与健康

[概念] 概念释义：城市化（Urbanization）：是指城市数量增加或城市规模扩大的过程，其结果表现为城市人口在社会总人口中的比例逐渐上升。

正向影响：使居民获得更好的教育、更多的收入和更高水平的医疗保险，更好的公共基础设施，进而改善居民健康水平。

负向影响——“城市病”：人口膨胀、交通拥堵、环境污染（从传统公共健康问题转向现代健康危机）、资源短缺、城市贫困。负向健康影响：环境污染加重、精神障碍增加、现代病出现、交通危害、城乡健康差距扩大、城市移民健康问题突出、卫生资源使用“拥挤效应”。

5.3 社会网络与健康

5.3.1 社会网络、人际关系与社会支持

！重点掌握：社会网络（Social Network）：是指社会个体成员之间因互动而形成的相对稳定的关系网。对个体的作用：影响选择与决策、提供信息、提供社会支持。

人际关系：是指人类社会中人與人相互联系和相互作用过程中形成的一种复杂的关系。和谐、融洽的人际关系是人们获得社会支持的情感条件，也是获得社会支持的基础。

社会支持（Social Support）：是指个体获得的来自于他人或社会网络的一般或特定的支持性资源。从性质上分为两类：

1. **客观的支持：**可见的或实际的，包括物质上的直接援助、团体关系的存在和参与等（物质支持和生活支持）
2. **主观的支持：**个体体验到的或情感上感受到的支持，指个体在社会中受尊重、被支持与理解的情感体验和满意程度，与个体的主观感受密切相关

对健康的影响：提供维护和促进健康所需要的物质资源；降低压力事件对个体身心健康的危害。

5.3.2 家庭与健康

！重点掌握：家庭的类型：

1. **核心家庭：**由一对夫妇及其未婚子女组成的家庭。特点：结构简单，一个权力和活动中心，容易沟通相处
2. **主干家庭：**两代及以上成员，每代只有一对夫妇。特点：一个主要权力和活动中心，一个次中心
3. **联合家庭：**同一代至少有两对及以上夫妇。特点：结构复杂，一个主要权力和活动中心，数个次中心
4. **其它家庭：**单身家庭、单亲家庭、同居家庭、同性恋家庭、隔代家庭等

家庭的功能：（1）生殖功能；（2）社会化功能；（3）情感功能；（4）健康照顾功能（工具性和情感性社会支持）；（5）经济功能。

家庭功能评定——APGAR 问卷：A（Adaptation）家庭遭遇危机时利用内外资源解决问题的能力；P（Partnership）家庭成员分担责任和共同作出决定；G（Growth）家庭成员通过互相支持达到身心成熟和

自我实现；A（Affection）家庭成员间相爱的程度；R（Resolve）家庭成员间共享时间/空间/金钱的程度。
家庭对健康和疾病的影响：遗传和先天的影响；家庭对儿童生长发育及社会化的影响；家庭环境对健康的影响；家庭对生活习惯和行为方式的影响；家庭对成年人发病率和死亡率的影响。

5.3.3 社会阶层与健康

[概念] 概念释义：社会阶层：指由财富、权利和威望不同造成的社会地位、生活方式等方面不同的社会基本层次。划分指标：经济地位/收入（主要指标）、职业、教育水平、社会声望。
社会阶层较低的人群：遭受更多不良刺激、缺乏足够社会支持、教育水平低影响处理应激能力、较多不良卫生习惯、较少卫生保健机会。社会阶层较高的人群：承受较高职业压力、情绪障碍性疾病发生率可能较高。

5.4 复习题

1. 【名词解释】负担系数；人口金字塔；社会支持；社会网络；核心家庭；社会阶层
2. 【简答题】简述人口年龄构成的常用指标及三种人口金字塔类型。
3. 【简答题】简述社会支持的概念、两种类型及其对健康的影响。
4. 【简答题】简述家庭的四种类型及家庭五大功能，APGAR 问卷的含义。
5. 【简答题】简述城市化对健康的正负向影响。
6. 【简答题】简述体力活动不足对健康的影响及 WHO 成人活动建议。

参考答案要点

1. **负担系数：**非劳动力人口数与劳动力人口数的比值，包括总负担系数、老年负担系数、少年儿童负担系数。
人口金字塔：用条形图表示人口性别年龄结构，分增长型、稳定型、缩减型。**社会支持：**个体获得的来自于他人或社会网络的一般或特定的支持性资源，分客观支持和主观支持。**核心家庭：**一对夫妇及其未婚子女组成的家庭，结构简单，一个权力和活动中心。**社会阶层：**由财富/权利/威望不同造成的社会地位/生活方式等不同的社会基本层次。
2. **指标：**老年人口系数（>60 岁 >10% 或 >65 岁 >7% 为老年型社会）、儿童少年人口系数、负担系数。三种类型：增长型（基底宽顶尖，年轻人比重大）、稳定型（底身宽度接近，塔尖收缩）、缩减型（底窄身宽，年轻人少中年人比例大）。
3. 分客观支持（可见或实际的，物质直接援助 + 团体关系存在参与）和主观支持（个体体验到或情感上感受到的，受尊重/被支持理解的情感体验和满意程度）。对健康影响：提供维护和促进健康所需物质资源；降低压力事件对身心健康的危害。
4. 四种类型：核心家庭（一对夫妇 + 未婚子女）、主干家庭（两代以上每代一对夫妇）、联合家庭（同代至少两对夫妇）、其它家庭。五大功能：生殖、社会化、情感、健康照顾、经济。APGAR：适应能力（Adaptation）、分担责任（Partnership）、成长（Growth）、情感（Affection）、共享（Resolve）。
5. 正向：更好教育/收入/医疗保险/公共基础设施 → 改善健康水平。负向（城市病）：人口膨胀、交通拥堵、环境污染、资源短缺、城市贫困 → 环境污染加重、精神障碍增加、现代病出现、交通危害、城乡健康差距扩大、移民健康问题突出。
6. 危害：缺乏体力活动是众多慢性病主要危险因素，WHO 列为全球死亡和残疾前 10 项原因。WHO 建议：每周至少 150 分钟中等强度或 75 分钟高强度有氧活动，每次至少 10 分钟，每周至少 2 天大肌群参与的强壮肌肉活动。

本章导览：掌握文化的概念；掌握文化对人群健康的影响及作用模式（难点*）；熟悉文化的构成（认知/规范/符号成分）、特征和类型；熟悉文化影响健康的五大特点；熟悉教育对健康的影响及途径；了解科技进步对健康的双面影响；了解风俗习惯、宗教对健康的影响。

6.1 文化的概念、构成及特征

[概念] 概念释义：文化：

- **广义文化：**人类在其生产和生活活动中所创造的一切社会物质财富和精神财富的总和。发明、产品等属于物质文化；语言、文字、观念、理论及艺术等属于精神文化
- **狭义文化（精神文化）：**人类的一切精神财富的总和，包括思想意识、观念形态、文学艺术、社会道德规范、法律、宗教信仰、风俗习惯、教育、科学技术、知识等

文化的构成：

1. **认知成分：**知识（对自然和社会的客观认识）和信仰（对自然和社会的主观认识）
2. **规范成分：**价值观（文化的核心，对事物和现象的认知评价——正确与错误/道德与失德/应该与不应该）和社会规范（指导日常行为的约定俗成的不成文规则和明文规定）
3. **符号成分：**任何能有意义表达的东西，不依赖于符号本身品质，能为同一社会文化背景中的人所认同。
最重要的文化符号成分：语言、文字

文化的特点：共有性、习得性、象征性。

文化的类型：**智能文化**（改造客观世界能力的经验总结，如生产知识/科学技术）；**规范文化**（明文规定的系列行为准则，如政治法律/伦理道德/风俗习惯/教育）；**思想文化**（思维活动对客观存在反映的精神产品，如思想意识/观念形态/宗教信仰/文学艺术）。

6.2 文化影响健康的模式与特点

！重点掌握：WHO 第六次报告指出：“一旦人们的生活水平达到或超过起码的需求，有条件决定生活资料的使用方式，文化因素对健康的作用就越来越重要了。”

不同文化类型对人群健康的作用模式：文化（物质文化 + 精神文化）→ 智能文化（生活资料/生产资料/生产知识/科学技术）→ 生活环境/劳动条件；规范文化（社会制度/政治法律/伦理道德/风俗习惯/教育）→ 生活方式与行为；思想文化（思想意识/观念形态/宗教信仰/文学艺术）→ 精神生活/心理状态 → 三者共同影响健康。

文化影响健康的特征：

1. **无形性**——潜移默化
2. **本源性**——文化根源
3. **软约束性**——自发行动
4. **稳定性**——代际传递
5. **民族性**——差异性

6.3 文化诸现象对健康的影响

6.3.1 教育对健康的影响

！重点掌握：教育具有两种职能：一是传播知识（按社会需要，属于智能规范）；二是传播社会准则（属于行为规范）。成功的教育是使人能够承诺一定的社会角色并有能力执行角色的功能。

教育水平与健康水平呈一定的正相关趋势。**教育对健康的影响途径：**

1. **人的社会化**——教育是人的社会化的过程和手段。社会化是指人从一个自然人转化为一个能够适应一定的社会环境、履行一定角色职能的社会人的进程
2. **生活方式的选择**——教育通过培养人的文化素质来指导人的生活方式
3. **对卫生服务的利用**——受教育程度较高者对卫生知识教育和宣传表现出渴求欲望，保护健康的意识浓烈，更主动积极寻求卫生服务
4. **就业机会和收入**——个体受教育程度越高 → 工作能力越强 → 获得就业机会和劳动收入越多 → 利用社会资源的能力越强 → 获得健康信息和服务的机会越多

6.3.2 科技进步与健康

[概念] 概念释义：科学技术是一把双刃剑。**正向作用：**诊疗技术提高；信息高速公路；智慧医疗（利用互联网技术和物联网技术通过智能化方式将医疗卫生服务相关的人员/信息/设备/资源连接起来实现良性互动）。

负向作用：高科技在诊疗中物化了医患关系，增加了对技术和机器的依从性（“高技术，低感情”）；提高了收费标准和病人期望值，但诊疗水平与治疗能力并不同步；容易造成过度诊疗；对自然的干预可能导致生活环境失调产生新的有害因素；信息安全问题。

6.3.3 风俗习惯与健康

[概念] 概念释义：概念：风俗指社会上长期形成的风尚、礼节等（对社会人群而言）；习惯指人们长期生活养成的、一时不易改变的行为倾向（对个人而言）。

特征：广泛性（涉及衣食住行各方面）、地区性（不同地区不同民族有不同习俗）、稳定性（与生产活动或心理需要相适应故能长期存在）、约束性（系规范文化，对人们行为有较强约束力）。有益于健康的习俗 → 提倡，不利于健康的习俗 → 改革。

6.3.4 宗教与健康

[概念] 概念释义：宗教是支配人们日常生活的自然力量和社会力量在人们头脑中主观的反映，是以神的崇拜和神的旨意为核心的信仰和行为准则的总和。宗教对健康的影响具有双面性：宗教的发展推动了医学的发展；宗教具有精神力量；宗教对行为产生影响。

6.4 复习题

1. **【名词解释】**文化（广义和狭义）；价值观；社会规范；社会化
2. **【简答题】**简述文化的构成（认知成分、规范成分、符号成分）和类型。
3. **【简答题】**试述不同文化类型对人群健康的作用模式。
4. **【简答题】**简述文化影响健康的五大特征。
5. **【简答题】**简述教育对健康的影响途径。
6. **【简答题】**简述风俗习惯的特征及其对健康的影响。

参考答案要点

1. **广义文化：**人类所创造的一切社会物质财富和精神财富的总和。**狭义文化（精神文化）：**人类一切精神财富总和。**价值观：**文化的核心，人们对事物和现象的认知评价，以正确与错误/道德与失德/应该与不应该形成基本观点。**社会规范：**指导日常行为的约定俗成的不成文规则和明文规定。**社会化：**人从自然人转化为能适应社会环境、履行角色职能的社会人的进程。
2. **三大构成：**认知成分（知识 + 信仰）、规范成分（价值观 + 社会规范）、符号成分（语言 + 文字等）。三种

类型：智能文化（生产知识/科学技术）、规范文化（政治法律/伦理道德/风俗习惯/教育）、思想文化（思想意识/观念形态/宗教信仰/文学艺术）。

3. 智能文化 → 生活环境/劳动条件；规范文化 → 生活方式与行为；思想文化 → 精神生活/心理状态 → 三者共同影响健康。
4. (1) 无形性（潜移默化）；(2) 本源性（文化根源）；(3) 软约束性（自发行动）；(4) 稳定性（代际传递）；(5) 民族性（差异性）。
5. 四条途径：(1) 人的社会化（教育是社会化和手段）；(2) 生活方式的选择（教育培养文化素质 → 指导生活方式）；(3) 对卫生服务的利用（受教育程度高 → 健康意识强 → 主动寻求服务）；(4) 就业机会和收入（教育 → 工作能力 → 收入 → 利用资源能力 → 健康信息和服务机会）。
6. 四大特征：广泛性（涉及衣食住行）、地区性（不同地区/民族习俗不同）、稳定性（与生产活动/心理需要相适应）、约束性（规范文化对行为有较强约束力）。影响：有益 → 提倡，不利 → 改革。

本章导览：掌握行为及健康相关行为的概念；掌握人格与健康（A/B/C 型性格）；熟悉现代压力基本理论（生物应激/社会事件刺激/心理认知/现代压力理论）和持久过大压力的不良后果；熟悉健康相关行为的基本特征；熟悉吸烟的危害与控烟政策措施（FCTC、MPOWER）；了解行为心理问题的干预方法（政策/环境/媒体/社区/组织干预）。

7.1 心理因素与健康

7.1.1 人格与健康

[概念] 概念释义：人格（Personality）：是稳定地表现于个体的心理特质，由遗传和环境共同决定，对人的社会化过程的作用举足轻重。

人格与健康：消极人格（抑郁、愤怒、敌意与焦虑）→ 较低健康水平；刚性人格（责任感、控制感、挑战性）→ 较好健康水平。

性格类型与疾病：

- **A 型性格：**急躁、缺乏耐性，具有敌意、匆忙和竞争的特点，与冠心病、高血压、溃疡病等有关
- **B 型性格：**不争强好胜、做事不慌不忙
- **C 型性格：**压抑自己的情绪，过分忍让，回避矛盾，怒而不发，好生闷气，内向——肿瘤的性格模型

7.1.2 心理压力与健康

！重点掌握：压力（Stress）/ 心理应激：是指人们生活中的各种刺激事件（应激源）和内在要求在心理上所构成的困惑或威胁，表现为心身紧张或不适。

压力基本理论：

1. **生物应激理论：**应激反应是生物体对某些情景自动的或激素反应（克劳德：机体对外界刺激所做出的适应性反应）
2. **社会事件刺激理论：**压力是外部压力事件的刺激作用（坎农）
3. **心理认知理论：**拉扎勒斯和福尔克曼强调人们对刺激事件的认知和解释的重要性
4. **现代压力理论（应激过程模型）：**将心理应激看作是由各种刺激事件（应激源）到应激反应的多因素作用过程

应激源分类：(1) 躯体性应激（直接对机体作用）；(2) 心理性应激源（人际冲突、个体强烈需求、能力不足与期望矛盾）；(3) 社会性应激源（客观社会学指标、社会变动与地位不合适）；(4) 文化性应激源（语言/风俗/习惯改变）。

持久过大压力的不良后果：(1) 健康问题——各类疾病（高血压、偏头疼、癌症、溃疡、关节炎、心血管病等），心理和行为问题（心理障碍、吸烟、酗酒、自杀和反社会行为）；(2) 工作问题——旷工、消极怠工、工作差错和事故增加；(3) 管理和决策问题——决策失误（建设性思维减少/扭曲性思维增加、危险性抉择增加、重视短期忽略长期目标）。

7.2 行为生活方式与健康

！重点掌握：行为（Behavior）：人类在内外因素共同作用下产生的外部活动。本能行为（先天性的，摄食/睡眠/性等）+ 社会行为（在社会文化环境中通过社会化过程获得的，锻炼/吸烟/酗酒等）。

健康相关行为（Health Related Behavior）：指个体或群体与健康 and 疾病有关的行为。分为：

- 促进健康的行为（Health-Promoted Behavior）：个体或群体表现出的、客观上有利于自身和他人健康的行为
- 危害健康的行为（Health-Risky Behavior）：偏离个人、他人和社会健康期望、不利于健康的行为

促进健康行为的基本特征：有利性、规律性、和谐性、一致性、适宜性。

行为因素与健康的关系：2008 年 WHO 调查显示，50% 的死亡是由于行为生活方式因素、30% 为环境因素、10% 为生物遗传因素、10% 为医疗卫生服务因素。发达国家的经验证实，通过行为干预，可使高血压发病率下降 55%，脑卒中下降 75%，糖尿病下降 50%，肿瘤下降 33%。

7.3 行为心理问题的干预

[概念] 概念释义：（一）政策干预——效益很高的措施，如公共场所禁烟计划、禁止吸烟广告。政府是政策制定的主体，需通过政策倡导促动来促使政府采纳和实施有利于人民健康的政策。倡导促动（PCPA 模式）：倡议（提出议题）→ 联盟（建立伙伴关系）→ 宣传（公开意图、设计讯息）→ 行动（游说和鼓动）。（二）环境工程设施干预——通过改善环境工程设施增加行为相关物的可得性或可及性，以增强行为干预效果。

（三）大众媒体干预——利用媒体影响大众和决策者的知识、观点、态度和行为，进行健康教育。

（四）社区干预——在社区层面进行疾病预防、控制、教育和咨询等活动。社区动员是社区干预的前提。

（五）组织干预——通过对不合理的组织结构和行为进行改变达到干预目标，分 4 个阶段：问题知觉 → 行动启动（采纳）→ 实施 → 定型化。

7.4 常见健康相关行为——吸烟与控烟

！重点掌握：吸烟的危害：心脑血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、生殖系统疾病、神经系统疾病、内分泌系统疾病。我国目前吸烟人数已超过 3 亿，遭受二手烟危害的非吸烟人群高达 7.4 亿，每年有 120 多万人死于烟草相关的疾病。

控烟的政策措施：

- 《烟草控制框架公约》（FCTC，2003 年）——WHO 首次制定的具有国际法约束力的全球公约。中国 2005 年批准，2006 年生效
- MPOWER 六项政策（WHO 2008 年）：(1) 监测烟草使用与预防政策（Monitor）；(2) 保护人们免受烟雾危害（Protect）；(3) 提供戒烟帮助（Offer）；(4) 警示烟草危害（Warn）；(5) 禁止烟草广告、促销和赞助（Enforce）；(6) 增加税收和提高烟价（Raise）

控烟倡导促动：政策倡导促动（针对决策者的社会行动，促使其出台控烟政策）+ 大众倡导促动（大众宣传 + 大众劝说）。

7.5 复习题

1. 【名词解释】人格；心理压力（心理应激）；健康相关行为；倡导促动（PCPA 模式）
2. 【简答题】简述 A/B/C 型性格的特征及其与疾病的关系。
3. 【简答题】试述现代压力理论（应激过程模型）及四种应激源。
4. 【简答题】简述促进健康行为的基本特征。
5. 【简答题】简述 WHO MPOWER 控烟六项政策措施。

参考答案要点

1. **人格**：稳定表现于个体的心理特质，由遗传和环境共同决定。**心理压力/应激**：生活中的各种刺激事件和内在要求在心理上构成的困惑或威胁。**健康相关行为**：个体或群体与健康 and 疾病有关的行为，分促进健康行为和危害健康行为。**PCPA 模式**：倡议—联盟—宣传—行动的倡导促动模式。
2. **A 型**：急躁/缺乏耐性/敌意/匆忙/竞争 → 冠心病/高血压/溃疡病。**B 型**：不争强好胜/做事不慌不忙。**C 型**：压抑情绪/过分忍让/回避矛盾/怒而不发/内向 → 肿瘤的性格模型。
3. **应激过程模型**：应激源 → 认知评价（受个性特征影响）→ 应对方式 + 社会支持 → 应激反应 → 适应或适应不良（身心疾病）。四种应激源：躯体性、心理性（人际冲突/需求矛盾）、社会性（社会学指标变化/社会地位变化）、文化性（语言/风俗/习惯改变）。
4. **五大特征**：(1) 有利性（有益于自己/他人/社会）；(2) 规律性（有恒常规律）；(3) 和谐性（有鲜明个性又能根据环境调整）；(4) 一致性（外显行为与内心一致）；(5) 适宜性（行为强度有理性控制，无明显冲动）。
5. **MPOWER 六项**：(1) 监测烟草使用与预防政策 (Monitor)；(2) 保护人们免受烟雾危害 (Protect)；(3) 提供戒烟帮助 (Offer)；(4) 警示烟草危害 (Warn)；(5) 禁止烟草广告/促销/赞助 (Enforce)；(6) 增加税收和提高烟价 (Raise)。

本章导览：掌握定性研究的概念、特点和常用方法（深入访谈、焦点小组讨论）；掌握问卷的概念、类型、结构和设计原则；掌握信度和效度的概念及类型（难点*）；掌握信度和效度的关系（难点*）；熟悉定量研究的概念和特点（访谈法/自填法的优缺点）；熟悉非概率抽样方法（偶遇/立意/雪球/定额）；熟悉社会医学研究的步骤和课题评价三原则。

8.1 社会医学研究方法概述

8.1.1 相关研究方法

[概念] 概念释义：社会医学的相关研究方法：调查研究、实验研究（现场实验/社区干预实验）、评价研究（生命质量评价/健康危险因素评价/卫生服务评价/卫生项目评价）、德尔菲法（核心是通过多轮函询征求专家对某一问题的意见）、文献研究（利用已有资料通过综合整理/分析/归纳达到研究目的）。

8.1.2 社会医学研究的步骤

[概念] 概念释义：第一步选择课题陈述假设 → 第二步制定研究方案 → 第三步收集资料 → 第四步整理和分析资料 → 第五步解释结果。

课题评价三原则：需要性原则、创造性原则、科学性原则。还需进行可行性论证（从技术和经济角度论证课题是否具备进行研究的条件）。

8.1.3 非概率抽样方法

！重点掌握：

1. **偶遇抽样（Accidental/Convenience Sampling）/ 便利抽样：**研究者根据现实情况使用最便利的方式选取样本，简单易行但对总体代表性差
2. **立意抽样（Purposive Sampling）/ 判断抽样：**调查者根据研究目的分析判断来选择调查对象，与研究目的有关，研究者的判断更为重要
3. **雪球抽样（Snowball Sampling）：**从总体中少数成员入手，请他们介绍所认识的其他符合条件的人，如同滚雪球一样找到越来越多具有相同性质的群体成员
4. **定额抽样（Quota Sampling）/ 配额抽样：**依据可能影响研究指标的各种因素对总体分层，确定各层样本比例，再在各层中抽取样本（可看成是分层抽样的延伸但不是随机抽样）

8.2 定量研究

[概念] 概念释义：定量研究（Quantitative Research）/ 量化研究：通过调查收集人群发生某种事件的数量指标，如患病率、就诊率等，或者探讨各种因素与疾病、健康间的数量依存关系的研究。

特点：优点——重点在研究假设，逻辑推理严谨；标准化和精确化程度高；可用概率统计方法检验；具有较好的客观性和科学性。局限——投入较大；难获得深层次或意料之外信息；一些社会因素及医学问题难以用数据指标表达；一些关系很难用定量结果解释。

收集资料方法：

- **访谈法（面对面访谈）**——优点：灵活、适用范围广（含文盲者）、回收率高、可判断真实性、可防第三者影响、可列入复杂问题。缺点：组织工作量大、耗费时间和人力物力、受调查员影响大可能出现访谈偏误、一般没有匿名保证
- **自填法**——主要有信访法、现场自填法。信访法优点：节省人力财力时间、有较高匿名保证、地理范围广。信访法缺点：回收率低、被调查者遇到问题无法得到解答、无法控制填写环境、无法判断回答真实性

8.3 问卷设计

！重点掌握：问卷（Questionnaire）/ 调查表：指有详细问题和可供选择的答案或只有问题而无答案的可用来提问收集资料的工具。

问卷结构：封面信（调查目的/内容/意义/请求合作）→ 指导语（填答说明/概念解释）→ 问题及答案（特征问题/行为问题/态度问题）→ 编码（问卷编码/问题编码/答案编码）。

问题设计：

- **开放式问题：**只有提问，没有备选答案，被调查者可自由回答。优点：可用于未知答案情况、能收集更多反映特征资料、灵活不受限制、答案过多（>10 种）时适用。缺点：可能得到无关信息、要求一定文化水平/语言表达能力、费时费力、应答率低、统计处理困难
- **封闭式问题：**在提问同时提供两个及以上备选答案，遵循独立原则和穷尽原则，一般要使至少 80% 回答者能找到自己的答案。优点：易回答省时、拒答率低应答率高、低文化程度也能答、敏感问题用等级资料更能获得真实回答、便于统计分析。缺点：有猜答和随便回答可能、答案不易穷尽、了解难以深入、容易笔误

答案格式种类：填空式、二项选择式、多项选择式、图表式（线性尺度和表格）、排序式。

问题排列原则：先易后难、封闭式在前开放式在后、问题排列要有逻辑顺序、检验信度的配对问题须分隔开来。

问卷设计原则：目的原则（每个问题都应与研究目的相关）、实用性原则（用词简明清楚准确、避免专业术语、回忆时间不宜过长）、反向性原则（从最终想要结果反推问题）。

问卷设计步骤：明确研究目的 → 建立问题库（头脑风暴法/借用其它问卷条目）→ 设计问卷初稿 → 试用和修改 → 信度与效度检验。

8.4 信度与效度（难点*）

！重点掌握：信度（Reliability）：指测量工具的稳定性，表示测量工具（主要指问卷）所获资料的可靠程度或可信程度，即测量的稳定性和一致性问题。

信度测量方式：

1. **复测信度（Test-Retest Reliability）：**采用同一问卷在同一人群中测量两次，评价两次测量的相关性
2. **复本信度（Alternate Form Reliability）：**设计另一种与研究问卷高度类似的问卷，同时测量研究对象
3. **折半信度（Split-Half Reliability）：**将一个问卷分拆为两半，分别作为各自的复本

效度（Validity）：调查结果与试图要达到的目标之间的接近程度，即调查的结果是否是需要的结果。评价的是偏倚问题，测量的真实性问题。

效度的种类：

1. **表面效度（Face Validity）：**从表面上看问卷条目是否都与研究者想了解的问题有关
2. **内容效度（Content Validity）：**评价问卷所涉及内容能在多大程度上覆盖研究目的达到的各个方面和领域（由专家进行主观评价）
3. **结构效度（Construct Validity）：**一个概念或命题按一定理论分解后形成相应结构，测量的实际结构与此一致的程度
4. **准则效度（Criterion Validity）：**问卷结构与某个“金标准”的一致性，即问卷调查结果与标准测量结果间的接近程度

信度和效度的关系（难点*）：

1. 不可信的测量一定是无效的（信度不高，效度也不会高）

2. 可信的测量既可能有效，也可能无效（信度高，效度不一定高）
3. 无效的测量既可能是可信的，也可能是不可信的（效度不高，信度可能高，也可能不高）
4. 有效的测量一定是可信的测量（效度高，信度一定也高）

8.5 定性研究

！重点掌握：定性研究（Qualitative Research）/ 质性研究：是一种在自然的情境下，从整体的角度深入探讨和阐述被研究事物的特点及其发生和发展规律，以揭示事物的内在本质的一类研究方法。

特点：注重事物的过程；小样本人群研究；需要与研究对象保持较长时间的接触；研究结果很少用概率统计分析。

应用：(1) 用于帮助问卷设计；(2) 验证因果关系，探讨发生机制；(3) 分析定量研究出现矛盾结果的原因；(4) 了解危险因素的变化情况；(5) 作为快速评价技术，为其它研究提供信息。

常用定性研究方法：

1. **深入访谈（In-Depth Interview）：**调查者与回答者进行一对一深入交谈来收集资料
2. **焦点小组讨论（Focus Group Discussion）：**由一位主持人带领，围绕某一主题进行自由、深入讨论（一般 6~10 人，1~2 小时），了解调查对象对某一问题的看法
3. **名义小组讨论（Nominal Group Discussion）**
4. **观察法（Observation）**

8.6 复习题

1. 【名词解释】定量研究；定性研究；问卷；信度；效度；德尔菲法
2. 【名词解释】偶遇抽样；立意抽样；雪球抽样；定额抽样
3. 【名词解释】复测信度；表面效度；内容效度；准则效度；结构效度
4. 【简答题】简述课题评价三原则和非概率抽样的四种方法。
5. 【简答题】简述面对面访谈法和信访法的优缺点。
6. 【简答题】简述开放式问题和封闭式问题的定义及其优缺点。
7. 【简答题】简述问卷的结构、设计原则和步骤。
8. 【简答题】简述信度和效度的概念、类型及其相互关系（难点*）。
9. 【简答题】简述定性研究的概念、特点、应用和常用方法。

参考答案要点

1. **定量研究：**通过调查收集人群发生某种事件的数量指标，探讨各种因素与疾病/健康间数量依存关系的研究。**定性研究：**在自然情境下从整体角度深入探讨和阐述被研究事物的特点及规律、揭示事物内在本质的研究方法。**问卷：**有详细问题和可供选择的答案或只有问题而无答案的可用来收集资料的工具。**信度：**测量工具的稳定性，表示所获资料的可靠程度。**效度：**调查结果与试图达到目标之间的接近程度，评价偏倚和真实性。**德尔菲法：**通过多轮函询征求专家意见的方法。
2. 偶遇抽样（最便利方式选取，代表性差）、立意抽样（根据研究目的分析判断选择，研究者的判断更为重要）、雪球抽样（从少数成员入手，滚雪球式扩大）、定额抽样（先分层确定比例再在各层抽取，非随机）。
3. 复测信度：同一问卷同一人群测两次评价相关性。表面效度：问卷条目从表面看是否与研究问题有关。内容效度：问卷内容覆盖研究目的各方面和领域的程度（专家主观评价）。准则效度：问卷结构与“金标准”的一致性。结构效度：概念按理论分解后测量的实际结构与之的一致程度。
4. 三原则：需要性、创造性、科学性 + 可行性论证。四种非概率抽样见第 2 题。
5. 面对面访谈优点：灵活、适用范围广、回收率高、可判断真实性、防第三者影响。缺点：组织工作量大、费时费力、受调查员影响大、无匿名保证。信访法优点：省人力财力时间、匿名保证高、地理范围广。缺点：回收率低、无法解答疑问、无法控制环境、无法判断真实性。

6. 开放式问题：只有提问无备选答案，自由回答。优点：未知答案情况适用、能收集更多资料、灵活。缺点：可能得无关信息、需文化水平、费时、应答率低、统计困难。封闭式问题：提供备选答案。优点：易答省时、应答率高、低文化可答、敏感问题更真实、便于统计。缺点：可能猜答、答案不易穷尽、难以深入了解、易笔误。
7. 结构：封面信 → 指导语 → 问题及答案 → 编码。设计原则：目的原则、实用性原则、反向性原则。步骤：明确目的 → 建立问题库 → 设计初稿 → 试用修改 → 信度效度检验。
8. 信度三类型：复测信度、复本信度、折半信度。效度四类型：表面效度、内容效度、结构效度、准则效度。信效度关系：(1) 不可信必无效；(2) 可信可能有效也可能无效；(3) 无效可能可信也可能不可信；(4) 有效必可信（效度高信度一定高）。
9. 特点：注重过程、小样本人群、长时间接触、很少用概率统计。应用：帮助问卷设计、验证因果关系、分析矛盾结果、了解危险因素变化、快速评价。常用方法：深入访谈、焦点小组讨论（6~10 人，1~2 小时）、名义小组讨论、观察法。

本章导览：掌握卫生服务研究的概念（难点*）；掌握卫生服务需要、需求、利用的概念及相互关系（难点*）；掌握卫生服务需要与利用的常用指标；熟悉卫生资源（卫生人力资源、卫生费用）的概念和评价指标；熟悉卫生服务综合评价（难点*）；了解卫生服务研究的意义、目的、内容和方法。

9.1 卫生服务研究概述

[概念] 概念释义：卫生服务研究（Health Services Research）：是探讨卫生服务的需要、需求、利用以及卫生资源的配置、卫生服务的质量等方面的问题，为卫生事业管理提供科学依据的研究领域。
研究内容：卫生服务需要/需求/利用、卫生资源配置、卫生服务质量、卫生服务评价等。
研究方法：描述性研究、分析性研究、实验性研究、评价性研究等。

9.2 卫生服务需要、需求与利用（难点*）

！重点掌握：（一）基本概念

- **卫生服务需要（Health Services Need）：**依据人们的实际健康状况与“理想健康状态”之间存在差距而提出的对医疗、预防、保健、康复等服务的客观需要，包括个人觉察到的需要和由医疗卫生专业人员判定的需要。分为**觉察到的需要（Perceived Need）**和**潜在需要（Potential Need）**
- **卫生服务需求（Health Services Demand）：**在一定时期内、一定价格水平上，人们愿意而且能够购买的卫生服务量
- **卫生服务利用（Health Services Utilization）：**实际发生的卫生服务的消费量，即有效需求量

（二）需要与需求的相互关系

需要是需求的前提，但需要不一定转化为需求。需要 > 需求（有需要但无购买意愿或能力）；需要 < 需求（无实际需要但产生需求，如过度诊疗）。

（三）影响卫生服务需要与利用的因素：人口因素、经济因素、文化教育因素、卫生资源配置、医疗保障制度等。

（四）卫生服务需要常用指标：

- 疾病频率指标： $\text{两周患病率} = \frac{\text{两周内患病人数}}{\text{调查人数}} \times 100\%$
- 慢性病患率率： $\text{慢性病患率} = \frac{\text{慢性病患者人数}}{\text{调查人数}} \times 100\%$
- 疾病严重程度指标：两周卧床率、两周停工/休学率、两周活动受限率

（五）卫生服务利用常用指标：

- $\text{两周就诊率} = \frac{\text{两周内就诊人次}}{\text{调查人数}} \times 100\%$
- $\text{年住院率} = \frac{\text{年住院人次}}{\text{调查人数}} \times 100\%$
- 未就诊率、未住院率

9.3 卫生资源

[概念] 概念释义：卫生资源（Health Resources）：是指提供卫生服务所需的人力、经费、设施、装备、药品、信息和知识技术等资源的总称。

卫生人力资源（Health Manpower）：是卫生资源最重要的组成部分，研究内容包括卫生人员数量、结构（学历/职称/专业/年龄）、分布（地区/城乡/机构间）。

卫生费用（Health Expenditure）：研究内容包括卫生费用来源（政府/社会/个人）、卫生费用分类（经常性费用/投资性费用）、卫生费用评价指标（卫生总费用占 GDP 百分比、人均卫生费用、政府卫生支出占财政支出百分比等）。

9.4 卫生服务综合评价（难点*）

[概念] 概念释义：卫生服务综合评价是通过对卫生服务需要、卫生服务利用和卫生服务资源三个方面的综合测量，评价卫生服务的效率、效益和效果。评价框架包括：高需要/低利用 → 资源不足；高需要/高利用 → 资源效率高；低需要/高利用 → 可能存在过度利用；低需要/低利用 → 资源闲置等。

9.5 复习题

1. 【名词解释】卫生服务研究；卫生服务需要；卫生服务需求；卫生服务利用
2. 【名词解释】卫生资源；卫生人力资源；卫生费用
3. 【简答题】简述卫生服务需要、需求、利用的概念及相互关系（难点*）。
4. 【简答题】简述影响卫生服务需要与利用的主要因素。
5. 【简答题】简述卫生服务需要和利用的常用指标。

参考答案要点

1. **卫生服务研究：**探讨卫生服务需要/需求/利用以及卫生资源配置、服务质量等问题的研究领域。**卫生服务需要：**依据实际健康状况与“理想健康状态”的差距而提出的对预防/医疗/保健/康复服务的客观需要，分觉察到的需要和潜在需要。**卫生服务需求：**在一定时期和价格水平上人们愿意且能够购买的卫生服务量。**卫生服务利用：**实际发生的卫生服务消费量，即有效需求量。
2. **卫生资源：**提供卫生服务所需的人力/经费/设施/装备/药品/信息/知识技术等总称。**卫生人力资源：**卫生资源最重要的组成部分，研究内容包括数量/结构/分布。**卫生费用：**广义指一定时期内为提供卫生服务所消耗的经济资源。
3. 需要是需求的前提，但需要不一定转化为需求。需要 > 需求（有需要但无购买意愿或能力）；需要 < 需求（无实际需要但产生需求如过度诊疗）。利用是实际发生的消费量 = 有效需求量。
4. 人口因素、经济因素、文化教育因素、卫生资源配置、医疗保障制度等。
5. 需要指标：两周患病率、慢性病患率、两周卧床率/休工休学率/活动受限率。利用指标：两周就诊率、年住院率、未就诊率、未住院率。

本章导览：掌握健康危险因素的概念、分类及特点；掌握健康危险因素评价的概念和步骤（难点*）；掌握危险分数的意义和来源（难点*）；掌握评价年龄和增长年龄的概念；掌握健康危险因素的个人评价和群体评价方法。

11.1 健康危险因素概述

[概念] 概念释义：健康危险因素（Health Risk Factors）：是指在机体内外环境中存在的与疾病发生、发展和死亡有关的诱发因素，即能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素。

分类：环境因素（自然环境 + 社会环境）、生物遗传因素、行为生活方式因素、卫生服务因素。

特点：潜伏期长、特异性弱、联合作用明显、广泛存在。

健康危险因素的作用过程：危险因素 → 机体 → 疾病 → 健康结局。

11.2 健康危险因素评价

！重点掌握：健康危险因素评价（Health Risk Factors Appraisal, HRA）：是研究危险因素与慢性病发病率及死亡率之间数量依存关系及其规律性的一种技术，研究人们生活在危险因素的环境中发生死亡或发病的概率，以及当改变不良行为、消除或降低危险因素时，死亡及发病危险降低的程度。

评价步骤（难点*）：

1. **收集资料：**（A）当地性别、年龄别疾病死亡率资料（作为平均危险水平）；（B）个人健康危险因素资料（通过问卷/体检/实验室检查等收集）。一般选择 10~15 种主要死亡原因作为研究对象
2. **将危险因素转换成危险分数：**危险分数是衡量某项危险因素对健康危害程度的指标。基准值为 1.0——=1.0 表示与人群平均水平相同，>1.0 表示危险度高于平均水平，<1.0 表示危险度低于平均水平
3. **计算组合危险分数：**多个危险因素综合作用时的危险分数（注意协同作用而非简单相加）
4. **计算评价年龄：**评价年龄 = 根据个人存在的各项危险因素计算出的总死亡危险相当于一般人群中多大年龄者的死亡危险水平
5. **计算增长年龄：**增长年龄 = 将个人存在的可改变危险因素去除后计算出的总死亡危险相当于的年龄
6. **计算危险降低程度：**危险降低程度 = (评价年龄 - 增长年龄) / 评价年龄 × 100%

个体评价方法：

- 评价年龄 > 日历年龄：存在危险因素
- 评价年龄 < 日历年龄：危险因素低于平均水平
- 增长年龄 < 评价年龄：有降低危险的潜力

群体评价方法：根据人群危险因素分布特征和危险程度，确定高危人群，评价干预效果。

11.3 复习题

1. **【名词解释】**健康危险因素；健康危险因素评价（HRA）；危险分数；评价年龄；增长年龄
2. **【简答题】**简述健康危险因素的概念、分类及特点。
3. **【简答题】**试述健康危险因素评价的六个步骤（难点*）。

- 4.【简答题】简述危险分数的意义和来源。
- 5.【简答题】简述健康危险因素的个体评价方法和群体评价方法。

参考答案要点

1. **健康危险因素**：机体内外环境中存在的与疾病发生/发展和死亡有关的诱发因素。**HRA**：研究危险因素与慢性疾病发病率及死亡率之间数量依存关系及其规律性的技术。**危险分数**：衡量某项危险因素对健康危害程度的指标，基准值 1.0， >1 危险度高， <1 危险度低。**评价年龄**：根据个人危险因素计算出的总死亡危险相当于一般人群中多大年龄者的水平。**增长年龄**：去除可改变危险因素后计算出的总死亡危险相当的年龄。
2. 四大类：环境因素（自然 + 社会）、生物遗传因素、行为生活方式因素、卫生服务因素。四大特点：潜伏期长、特异性弱、联合作用明显、广泛存在。
3. (1) 收集资料（A. 当地性别年龄别疾病死亡率 B. 个人危险因素资料，选 10~15 种主要死因）；(2) 危险因素 → 危险分数；(3) 计算组合危险分数；(4) 计算评价年龄；(5) 计算增长年龄；(6) 计算危险降低程度。
4. 危险分数是衡量某项危险因素对健康危害程度的指标，基准值为 1.0（与人群平均水平相同）。 >1.0 危险度高于平均水平， <1.0 低于平均水平。来源：通过流行病学研究（队列研究为主）获得的相对危险度转换而来。
5. 个体评价：比较评价年龄与日历年龄、增长年龄与评价年龄。群体评价：根据人群危险因素分布特征和危险程度确定高危人群，评价干预效果。

本章导览：掌握生命质量（QOL）的概念与构成；掌握生命质量的评价方法（难点*）；熟悉生命质量的测量工具（如 SF-36、WHOQOL 等）；熟悉生命质量评价的应用（QALY 计算等）；了解健康相关生命质量（HRQOL）的概念。

12.1 生命质量的概念与构成

[概念] 概念释义：生命质量（Quality of Life, QOL）：WHO 定义——不同文化和价值体系中的个体对与他们的目标、期望、标准以及所关心的事情有关的生存状态的体验。

生命质量的构成：(1) 生理状态（活动能力、角色功能等）；(2) 心理状态（情绪、认知、自我评价等）；(3) 社会功能状态（社会交往、社会角色、社会支持等）；(4) 主观判断与满意度（对自身健康的总体感受和满意度）；(5) 对疾病和健康的特殊感受（QOL 的疾病特异性维度）。

健康相关生命质量（Health-Related Quality of Life, HRQOL）：指个体对疾病和特定健康状态对其生活质量所造成影响的主观体验和评价，是 QOL 在健康领域的应用。

12.2 生命质量的评价方法（难点*）

！重点掌握：生命质量的评价内容：躯体功能（活动能力、日常生活能力、角色功能）、心理功能（情绪、认知、心理应激）、社会功能（社会交往、社会支持）、主观健康（总体健康自评、健康满意度）。

评价方法：

1. **访谈法：**通过面对面或电话访谈收集信息
2. **观察法：**通过直接观察个体行为来评价
3. **量表法（最常用）：**使用标准化量表进行测量

常用测量工具：SF-36（36 条目简明健康调查量表，含 13 个维度，是国际上最常用的普适性量表之一）、WHOQOL（WHO 生命质量量表，含 100 个问题或简化为 26 个问题的 WHOQOL-BREF）。

量表评价要点：信度（可靠性）、效度（准确性）、反应度（敏感性）。

12.3 生命质量评价的应用

[概念] 概念释义：生命质量评价的应用领域：

1. 临床治疗方案的评价与选择
2. 人群和患者的健康状况评价
3. 预防性干预及保健措施的效果评价
4. 卫生资源配置与利用的决策
5. 健康影响因素与防治重点的选择

QALY（Quality-Adjusted Life Years, 质量调整生存年）：

$QALY = \sum W_k \times Y_k$ （ W_k 为处于 k 状态的权重值， Y_k 为处于 k 状态的年数）。是一种将生存质量和生存时间结合的综合指标，用于比较不同卫生干预措施的成本-效果（COST/QALY）。

12.4 复习题

1. 【名词解释】生命质量（QOL）；健康相关生命质量（HRQOL）；QALY
2. 【简答题】简述生命质量的构成（五个维度）。
3. 【简答题】简述生命质量评价的主要方法和内容。
4. 【简答题】简述生命质量评价的应用领域。

参考答案要点

1. **QOL**: WHO 定义——不同文化和价值体系中的个体对与他们的目标/期望/标准及所关心事情有关的生存状态的体验。**HRQOL**: 个体对疾病和特定健康状态对其生活质量影响的主观体验和评价。**QALY**: 质量调整生存年 = $W_k \times Y_k$ ，将生存质量和生存时间结合的综合指标，用于比较不同卫生干预措施的成本-效果。
2. 五个维度：(1) 生理状态（活动能力/角色功能）；(2) 心理状态（情绪/认知/自我评价）；(3) 社会功能状态（社会交往/角色/支持）；(4) 主观判断与满意度（总体健康感受/满意度）；(5) 对疾病和健康的特殊感受（疾病特异性维度）。
3. 评价内容：躯体功能 + 心理功能 + 社会功能 + 主观健康。评价方法：访谈法、观察法、量表法（最常用，如 SF-36、WHOQOL）。评价要点：信度、效度、反应度。
4. (1) 临床治疗方案评价与选择；(2) 人群和患者健康状况评价；(3) 预防性干预及保健措施效果评价；(4) 卫生资源配置与利用决策；(5) 健康影响因素与防治重点选择。

本章导览：掌握社会卫生状况的概念和人群健康状况的评价指标（单一型指标和复合型指标：PYLL、DALY 等）（难点*）；掌握健康影响因素指标（人口学指标、HDI、ASHA、PQLI 等社会发展指标）（难点*）；掌握健康公平指标（基尼系数、集中指数）；熟悉健康中国 2030 战略；熟悉 21 世纪人人享有卫生保健、初级卫生保健（PHC）的概念和基本原则；了解全球卫生策略（MDGs、SDGs）。

13.1 社会卫生状况概述

[概念] 概念释义：社会卫生状况（Social Health Status）：指人群的健康状况，以及影响人群健康的各种社会因素的综合状态。

WHO 定义：人群健康状况包括人口学特征、疾病和健康状况、生长发育和营养状况、社会环境条件等。

13.2 人群健康状况的评价指标（难点*）

13.2.1 单一型指标

[概念] 概念释义：

- **生命统计指标：**出生率、死亡率（总死亡率、年龄别死亡率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率）、期望寿命
- **疾病统计指标：**发病率、患病率、感染率、病死率
- **生长发育指标：**身高、体重、头围等指标的年增长值

13.2.2 复合型指标（难点*）

！重点掌握：1. 潜在减寿年数（Potential Years of Life Lost, PYLL）：

$PYLL = \sum (\text{目标年龄} - \text{各年龄组死亡年龄中位数}) \times \text{各年龄组死亡人数}$ 。通常以 1~70 岁为目标年龄。反映“早死”对人群寿命的影响，是衡量某种死因对一定年龄范围内某人群危害程度的指标。

2. 无残疾期望寿命（Life Expectancy Free of Disability, LEFD）：以生活自理能力丧失率为基础计算，反映人群在健康状态下生存的期望年数。

3. 活动期望寿命（Activity Life Expectancy, ALE）：反映人们能够维持良好日常生活活动能力（ADL）的期望寿命。

4. 伤残调整生命年（Disability Adjusted Life Year, DALY）：

$DALY = YLL$ （早死所致生命损失年）+ YLD （伤残所致健康生命损失年）。是衡量疾病负担的综合指标，常用于比较不同疾病对人群健康的影响。

5. 健康期望寿命（Healthy Life Expectancy, HALE）：WHO 开发，反映人群在完全健康状态下生存的期望年数。

13.2.3 健康影响因素指标（难点*）

！重点掌握：（一）人口学指标：人口数量、人口分布、性别构成、年龄构成、人口自然增长。

（二）社会发展指标：

- **人类发展指数（Human Development Index, HDI）**：由三个指标构成——期望寿命（权重 2/3）、教育水平（权重 1/3）、人均 GDP。 $HDI = (\text{期望寿命指数} \times \text{教育指数} \times \text{GDP 指数})$ 的几何平均
- **美国社会健康协会指标（American Social Health Association, ASHA）**： $ASHA = (\text{就业率} \times \text{识字率} \times \text{平均期望寿命} / 70 \times \text{人均 GDP 增长率}) / (\text{出生率} \times \text{婴儿死亡率})$
- **物质生活质量指数（Physical Quality of Life Index, PQLI）**： $PQLI = (\text{识字率指数} + \text{婴儿死亡率指数} + 1 \text{ 岁期望寿命指数}) / 3$ 。PQLI > 80 为高生活质量，< 60 为低生活质量
- **社会进步指数（SSPS）**
- **国民幸福指数（National Happiness Index, NHI）**

（三）健康公平指标：

- **基尼系数（Gini Coefficient）**：反映社会收入分配公平程度，取值范围 0~1，越接近 0 越公平
- **集中指数（Concentration Index）**：反映健康水平在不同社会经济阶层中的分布情况

13.3 健康中国与健康策略

13.3.1 健康中国 2030

[概念] 概念释义：“健康中国 2030”规划纲要提出分三步走战略目标：2020 年全面实现小康社会目标下的人群健康水平提升；2030 年主要健康指标进入高收入国家行列；2050 年建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。核心内容：健康生活、健康服务、健康保障、健康环境、健康产业五大战略领域。

13.3.2 21 世纪人人享有卫生保健

[概念] 概念释义：总目标：(1) 提高全体人民的期望寿命和生活质量；(2) 在国家之间和国家内部改进健康公平；(3) 使全体人民能利用可持续发展的卫生系统所提供的服务。

实施策略：(1) 将卫生列入可持续发展议程；(2) 部门合作与社区参与；(3) 合理配置卫生资源。

13.3.3 初级卫生保健

！重点掌握：初级卫生保健（Primary Health Care, PHC）/ 基层卫生保健：是基本的卫生保健服务，它依靠切实可行、学术上可靠又为社会所接受的方式和技术，是社区的个人和家庭通过积极参与普遍能够享受的，费用也是社区或国家在发展的各个时期本着自力更生及自决的精神能够负担得起的。

基本原则：(1) 合理布局（公平性）；(2) 社区参与；(3) 预防为主；(4) 适宜技术；(5) 综合利用。

基本要素（八项）：(1) 健康教育；(2) 食品供应和合理营养；(3) 安全饮用水和环境卫生；(4) 妇幼保健和计划生育；(5) 主要传染病的预防接种；(6) 地方病防治；(7) 常见病和外伤的合理治疗；(8) 基本药物供应。

13.3.4 千年发展目标（MDGs）与可持续发展目标（SDGs）

[概念] 概念释义：MDGs（2000~2015）：8 个目标，包括消灭极端贫穷和饥饿、普及小学教育、促进性别平等、降低儿童死亡率、改善孕产妇健康、与艾滋病/疟疾和其他疾病斗争、确保环境可持续性、全球合作促进发展。

SDGs（2015~2030）：17 个可持续发展目标，健康目标是 SDG3——“确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉”。

13.4 复习题

1. 【名词解释】社会卫生状况；PYLL；DALY；HALE；HDI；PHC

2. 【名词解释】ASHA；PQLI；基尼系数；集中指数

3. 【简答题】简述人群健康状况的复合型评价指标（PYLL、DALY 等）。
4. 【简答题】简述社会发展指标（HDI、ASHA、PQLI）的构成。
5. 【简答题】简述 21 世纪人人享有卫生保健的总目标和实施策略。
6. 【简答题】简述初级卫生保健（PHC）的概念、基本原则和基本要素。

参考答案要点

1. **社会卫生状况**：人群的健康状况及影响人群健康的各种社会因素的综合状态。**PYLL**：潜在减寿年数，反映“早死”对寿命影响的指标（1~70 岁）。**DALY**：伤残调整生命年 = YLL（早死损失年）+ YLD（伤残损失年）。**HALE**：健康期望寿命，反映完全健康状态下生存的期望年数。**HDI**：人类发展指数 = (期望寿命指数 + 教育指数 + GDP 指数) 的几何平均。**PHC**：初级卫生保健/基层卫生保健。
2. **ASHA**：美国社会健康协会指标 = (就业率 × 识字率 × 期望寿命/70 × 人均 GDP 增长率) / (出生率 × 婴儿死亡率)。**PQLI**：物质生活质量指数 = (识字率 + 婴儿死亡率 + 1 岁期望寿命三指数)/3，>80 高生活质量，<60 低生活质量。**基尼系数**：反映社会收入分配公平程度。**集中指数**：反映健康水平在不同社会经济阶层中的分布。
3. $PYLL = (70 - \text{死亡年龄中位数}) \times \text{死亡人数}$ ，衡量死因对人群危害程度。 $DALY = YLL + YLD$ ，衡量疾病负担。**HALE** 反映完全健康状态下生存期望。**LEFD** 以生活自理能力丧失率为基础。**ALE** 反映维持良好日常生活活动能力的期望寿命。
4. $HDI = (\text{期望寿命指数} \times \text{教育指数} \times \text{GDP 指数})$ 的几何平均，期望寿命权重 2/3、教育 1/3。**ASHA(美)** = (就业率 × 识字率 × 期望寿命/70 × 人均 GDP 增长率)/(出生率 × 婴儿死亡率)。 $PQLI = (\text{识字率} + \text{婴儿死亡率} + 1 \text{ 岁期望寿命})/3$ ，>80 高生活质量。
5. 总目标：(1) 提高全体人民期望寿命和生活质量；(2) 国家间和国内改进健康公平；(3) 使全体人民利用可持续发展的卫生系统服务。实施策略：将卫生列入可持续发展议程、部门合作与社区参与、合理配置卫生资源。
6. **PHC 概念**：基本的卫生保健服务，依靠切实可行/学术可靠/社会接受的方式和技术，社区个人和家庭通过积极参与普遍能享受，费用是社区或国家能负担得起的。五原则：合理布局（公平）、社区参与、预防为主、适宜技术、综合利用。八要素：健康教育、食品营养、安全饮水环境卫生、妇幼保健计划生育、主要传染病预防接种、地方病防治、常见病外伤合理治疗、基本药物供应。

本章导览：掌握健康管理产生的背景、概念和内涵；掌握健康管理的基本步骤和策略（难点*）；掌握健康治理的概念及特点；熟悉健康管理与健康治理的联系与区别；熟悉以社区为基础的、卫生系统的和国家层面的健康管理治理；了解全球健康治理。

16.1 健康管理

16.1.1 健康管理的概念和内涵

[概念] 概念释义：健康管理（Health Management）：是对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评估，提供健康咨询和指导以及对健康危险因素进行干预的全过程。

健康管理的内涵：(1) 以健康为中心，以预防为主；(2) 强调全人群和全生命周期的健康管理；(3) 重视健康危险因素的评估和控制；(4) 强调信息化手段的应用。

现代健康管理的新特点：从疾病管理向健康管理转变；从个体管理向群体管理延伸；从被动管理向主动管理转变；信息化、智能化水平不断提高。

健康管理的基本步骤（五步）：

1. 健康信息采集
2. 健康风险评估
3. 健康干预计划制定
4. 健康干预实施
5. 健康管理效果评价

健康管理策略（难点*）：生活方式管理策略、需求管理策略、疾病管理策略、灾难性伤病管理策略、残疾管理策略、综合人群健康管理策略。

16.1.2 以社区为基础的健康管理与治理

[概念] 概念释义：以社区卫生服务为基础，通过健康档案建立、健康风险评估、个体化和群体化健康干预、社区动员等手段实施健康管理。社区健康管理是落实基本公共卫生服务的重要载体。

16.2 健康治理

[概念] 概念释义：健康治理（Health Governance）：是指政府、社会组织和个人等多元主体共同参与健康事务的管理和决策过程，强调多元主体的协同合作、共同治理。

健康治理的特点：(1) 多元主体参与；(2) 协同合作；(3) 信息公开透明；(4) 责任共担。

健康管理与健康治理的联系与区别：

健康管理侧重于技术层面——对个体或群体的健康状况进行监测、评估和干预，预防和控制疾病。健康治理侧重于制度层面——通过多元主体的协同参与，制定和实施有利于人群健康的公共政策和制度安排。两者相辅相成：健康管理需要健康治理提供的政策和制度保障；健康治理需要健康管理提供的技术和方法支撑。

16.3 各层面的健康管理 with 治理

[概念] 概念释义：卫生系统健康管理 with 治理：医保支付方式改革、基本药物制度、分级诊疗制度建设、公立医院改革等。

国家健康管理 with 治理：健康中国 2030 战略、国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫工程等。

全球健康治理：WHO 在全球卫生事务中的领导和协调作用、全球疾病防控合作机制、国际卫生条例 (IHR) 的实施等。

16.4 复习题

1. **【名词解释】** 健康管理；健康治理；社区健康管理
2. **【简答题】** 简述健康管理的基本步骤（五步）和主要策略。
3. **【简答题】** 简述健康治理的概念及特点。
4. **【简答题】** 简述健康管理与健康治理的联系与区别。

参考答案要点

1. **健康管理：**对个体或群体的健康进行全面监测/分析/评估，提供健康咨询和指导以及对健康危险因素进行干预的全过程。**健康治理：**政府/社会组织和个人等多元主体共同参与健康事务的管理和决策过程。**社区健康管理：**以社区卫生服务为基础的健康管理方式。
2. 五步：(1) 健康信息采集 → (2) 健康风险评估 → (3) 健康干预计划制定 → (4) 健康干预实施 → (5) 健康管理效果评价。六种策略：生活方式管理、需求管理、疾病管理、灾难性伤病管理、残疾管理、综合人群健康管理。
3. 四大特点：(1) 多元主体参与；(2) 协同合作；(3) 信息公开透明；(4) 责任共担。
4. 健康管理侧重于技术层面（监测/评估/干预/防控疾病），健康治理侧重于制度层面（多元主体协同参与/制定实施有利健康的公共政策和制度安排）。相辅相成：管理需要治理提供的政策制度保障，治理需要管理提供的技术方法支撑。

本章导览：掌握社区的定义、类型和要素；掌握社区卫生服务（CHS）的概念、对象和特点（难点*）；掌握全科医学的概念；熟悉社区卫生服务的内容和意义；熟悉社区卫生服务的管理（难点*）和方式；了解社区卫生服务发展概况和绩效评价。

17.1 社区与社区卫生服务概述

17.1.1 社区

[概念] 概念释义：社区（Community）：

1. 以一定地理区域为基础的社会群体
2. 由具有共同文化、共同利益和共同意识的人群组成的社会单位
3. WHO 定义：社区是指一固定的地理区域范围内的社会团体，其成员有着共同的兴趣，彼此认识且互相来往，行使社会功能，创造社会规范，形成特有的价值体系和社会福利事业

构成社区的要素：(1) 一定的人口（人的因素）；(2) 一定的地域（空间因素）；(3) 一定的生活服务设施；(4) 特有的文化背景和生活方式；(5) 一定的生活制度和管理机构。

社区类型：地域型社区（城市社区、农村社区）、功能型社区（企业/学校/军营等）。

17.1.2 社区卫生服务

！重点掌握：社区卫生服务（Community Health Service, CHS）：是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

CHS 的对象：全体社区居民，包括健康人群、亚健康人群、高危人群、重点保健人群（妇女/儿童/老年人/慢性病人/残疾人/贫困居民）和病人。

全科医学（General Practice）：是整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会学科相关内容为一体的综合性医学专业学科，是社区卫生服务的核心学科。

CHS 的特点（难点*）：

1. **以健康为中心**——非以疾病为中心
2. **以人群为对象**——非以个体为对象
3. **以家庭为单位**——考虑家庭背景进行综合服务
4. **以社区为范围**——主动服务于社区中全体居民
5. **提供综合服务**——融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务六位一体
6. **提供连续性服务**——从生到死的全程服务
7. **提供可及性服务**——地理上接近、技术上适宜、经济上可负担
8. **提供协调性服务**——协调利用各种资源
9. **提供个体化服务**——以人为本
10. **以需求为导向**——根据居民需求确定服务内容

CHS 的服务方式：门诊服务、出诊/家庭访视、家庭病床、社区急救、转诊服务、健康管理服务等。

17.1.3 社区卫生服务的意义

[概念] 概念释义：

1. 是提供基本卫生服务、满足人民群众日益增长的卫生服务需求的重要途径
2. 是深化卫生改革、建立与社会主义市场经济体制相适应的城市卫生服务体系的重要基础
3. 是建立城镇职工基本医疗保险制度的迫切要求
4. 是加强社会主义精神文明建设、密切党群干群关系、维护社会稳定的重要途径
5. 是逐步实现“人人享有卫生保健”目标的重要策略

17.2 社区卫生服务的管理（难点*）

[概念] 概念释义：CHS 管理的内容：

1. **组织管理**：建立健全社区卫生服务网络，明确各级各类机构的职责和任务
 2. **人员管理**：全科医师、社区护士等社区卫生服务人员的培训、考核和管理
 3. **质量管理**：建立服务质量标准和评价体系
 4. **信息管理**：建立居民健康档案，实施信息化管理
 5. **财务管理**：合理使用社区卫生服务经费
 6. **绩效评价**：对社区卫生服务的效率、效益、效果进行综合评估
- 绩效评价维度**：可及性、有效性、效率、公平性、满意度等。

17.3 复习题

1. 【名词解释】社区；社区卫生服务（CHS）；全科医学
2. 【简答题】简述构成社区的五大要素。
3. 【简答题】简述社区卫生服务的特点（难点*）。
4. 【简答题】简述社区卫生服务的对象和意义。
5. 【简答题】简述社区卫生服务管理的主要内容。

参考答案要点

1. **社区**：一固定地理区域范围内的社会团体，成员有共同兴趣/彼此认识/互相来往/行使社会功能/创造社会规范/形成特有价值体系和社会福利事业。**CHS**：社区建设的重要组成部分，在政府领导/社区参与/上级指导下的基层卫生服务，六位一体。**全科医学**：整合临床/预防/康复医学及人文社会学科为一体的综合性医学专业学科，社区卫生服务的核心学科。
2. 五大要素：(1) 一定的人口；(2) 一定的地域；(3) 一定的生活服务设施；(4) 特有的文化背景和生活方式；(5) 一定的生活制度和管理机构。
3. 十大特点：(1) 以健康为中心；(2) 以人群为对象；(3) 以家庭为单位；(4) 以社区为范围；(5) 提供综合服务（六位一体：预防/医疗/保健/康复/健康教育/计划生育技术）；(6) 连续性服务；(7) 可及性服务；(8) 协调性服务；(9) 个体化服务；(10) 以需求为导向。
4. 对象：健康人群 + 亚健康人群 + 高危人群 + 重点保健人群（妇女/儿童/老年人/慢性病人/残疾人/贫困居民）+ 病人。意义：(1) 满足基本卫生服务需求的重要途径；(2) 深化卫生改革建立服务体系的重要基础；(3) 建立医保制度的迫切要求；(4) 加强精神文明建设维护社会稳定；(5) 实现“人人享有卫生保健”目标的重要策略。
5. 六大内容：组织管理、人员管理、质量管理、信息管理、财务管理、绩效评价（可及性/有效性/效率/公平性/满意度等维度）。

本章导览：掌握社会病的概念和特点；掌握自杀的概念、分类和预防；熟悉社会病的社会根源；熟悉人际暴力（难点*）的概念；了解成瘾行为/吸毒/问题饮酒行为/与性行为相关的社会病/青少年妊娠/精神障碍等社会病的防治。

21.1 社会病概述

！重点掌握：相关概念：

- **社会问题（Social Problem）：**从社会功能和社会发展的角度来看，需要调动社会力量加以解决的各种各样的问题（外延广）
- **越轨行为（Deviant Behavior）：**从个人与社会的关系角度来看，凡是违背群体标准或期望的行为（外延小），各种违法违纪行为和犯罪行为

如果越轨行为影响了社会的稳定和发展，就有可能成为社会问题。如果成为社会问题的越轨行为主要是由社会的原因引起的，而且与躯体和心理健康相关，就构成了所谓的“社会病”。

社会病（Sociopath / Social Pathology）：定义为“主要由社会本身的原因造成的，与社会发展和进步方向相违背的、危害人群健康的社会性现象”。

社会病的特点：

1. **社会病必须具有社会性**——如某社区中相当比例的成年人或青少年酗酒，成为家庭暴力、危险驾驶、消耗大量医疗资源的原因，此时需要分析该社区酗酒的社会原因
2. **社会病的产生根源非常复杂，但主要在于社会**——社会病可能与个人行为、个人的生物学特征有密切联系，但个人行为或特征不是产生社会病的主要和决定性原因
3. **社会病对社会具有严重的危害性**——可能破坏社会稳定，阻碍经济发展，降低社会生活质量
4. **社会病的防治需要全社会综合施策、共同努力**——如改变不合适的社会公共政策，建立健康的社会文化等
5. **社会病既是社会问题，也是健康问题或公共卫生问题**——社会医学对社会病研究的主要目的在于揭示社会病产生的根源，为降低社会病的发生和发展提供依据和政策建议

社会医学研究社会病的主要内容：(1) 社会病在人群中的发生率、发展变化规律和人群分布特征；(2) 社会病对个体和群体健康的影响，其导致的经济与社会负担；(3) 导致社会病产生的根源，特别是社会文化根源；(4) 社会病的防控措施。

相关的社会病类型：自杀、成瘾行为（吸毒/问题饮酒行为）、非故意伤害、攻击与暴力、精神障碍、性传播疾病、与性行为相关的社会病、青少年妊娠等。

21.2 自杀行为

21.2.1 自杀的概念与分类

！重点掌握：自杀（Suicide）：个人在意识清楚的情况下，自愿地（而不是被别人所逼迫）、有意地采取结束自己生命的行为。

自杀行为分类：

1. **自杀意念：**有明确结束自己生命的意愿，但没有付诸任何导致结束生命的实际行动
2. **自杀计划：**在自杀意念的基础上形成了如何结束自己生命的计划，但没有进行任何实际的准备，更没有采取任何实际的行动

3. **自杀准备**：在自杀意念和自杀计划的基础上做了自杀准备，但没有采取导致结束生命的行动
4. **自杀未遂**：在自杀意念的基础上采取了结束自己生命的行动，但该行动没有直接导致死亡的结局
5. **自杀死亡**：在自杀意念的基础上采取了结束自己生命的行动，该行动直接导致了死亡的结局

与自伤的区别和联系：**自伤 (Self-Injury)** 指在个人意识清楚的情况下，自愿地采取自我致伤、致残的行为，但完全没有结束自己生命的主观意愿。自伤行为不是自杀行为，但可能自伤后得不到及时救治也会导致死亡。在自杀预防中，一般把自伤行为当做“准自杀行为”而给予重视。

21.2.2 自杀的发生率与分布

[概念] 概念释义：WHO 估计，2012 年全球有 80.4 万人自杀死亡，经年龄标准化后的全球年自杀率为 11.4/10 万（男性 15.0/10 万，女性 8.0/10 万）。2012 年自杀占全球所有死亡原因的 1.4%，是导致死亡的第十五位原因。15~29 岁人群的自杀占该年龄段全部死亡的 8.5%，并且是该年龄段人群的第二位死亡原因（仅次于交通事故）。

21.2.3 自杀的社会根源

[概念] 概念释义：1. 社会关系——迪尔凯姆 (Durkheim) 的自杀分类：

- **自我性自杀 (Egoistic Suicide)**：社会整合程度低
 - **利他性自杀 (Altruistic Suicide)**：社会整合程度高
 - **失范性自杀 (Anomic Suicide)**：社会规范弱
 - **宿命性自杀 (Fatalistic Suicide)**：社会规范过强
2. **应激**——自杀行为成为应对精神紧张、心理冲突的一种方式。
 3. **文化**——包括文化对自杀行为的态度；文化源性应激；社会文化变迁对社会关系/生活方式和个人行为的重大影响。
 4. **自杀手段的可及性**
 5. **医疗卫生服务及其可及性**——可及的精神卫生服务有可能预防精神障碍患者自杀；可及的急救服务可以挽救死亡意愿非常强烈的自杀者的生命。

21.2.4 自杀的预防

！重点掌握：

1. **建立国家自杀预防战略**——自杀预防是一项系统工程。截至 2014 年，有 28 个国家建立自杀预防战略
2. **提高人群的心理健康素质**——普及心理卫生常识；学校开设心理卫生课程，开展心理技能训练；建立社区心理咨询和心理保健系统
3. **指导媒体有关自杀事件的报道**——WHO 提出应平衡报告自杀问题，积极宣传自杀预防知识，减少对自杀案例的渲染
4. **普及有关自杀和自杀预防的知识**
5. **减少自杀的机会**——加强武器管理；加强对有毒物质的管理；加强对危险场所的防护和管理
6. **建立预防自杀的专门机构**——自杀预防中心、危机干预中心、生命热线等
7. **对医务工作者和心理咨询工作者进行培训**——提高自杀行为的识别能力和救治能力
8. **提供完善的精神卫生服务**——防治精神障碍：抑郁症、精神分裂症、酒瘾、药瘾
9. **加强学校和工作场所的自杀预防工作**——建立心理卫生服务网络，及时发现和转诊可能处于自杀危险中的个体
10. **关注自杀死亡者的亲人**——关注心理调适和自杀预防

21.3 其他社会病

21.3.1 成瘾行为

[概念] 概念释义：**吸毒**：指非医疗目的使用麻醉药品和精神药品的行为，对个体和社会造成严重危害。

问题饮酒行为：酗酒是指无节制地过量饮酒，涵盖“酒精滥用”及“酒精依赖”。酒精滥用程度加重后，把饮酒看成比任何其他事都重要，或必须喝酒才感到舒服（心理依赖），就达到“酒精依赖”的程度。酗酒危害包括急性（急性酒精中毒、家庭不和、车祸/暴力）和慢性（酒瘾综合征、脂肪肝/肝硬化、心血管疾病、

神经精神疾病等)。

21.3.2 攻击与暴力

[概念] 概念释义：人际暴力（难点*）：指人与人之间蓄意运用躯体力量或权力对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害的行为。包括家庭暴力、校园暴力、社区暴力等。是重要的公共卫生问题和社会问题。

21.4 复习题

1. 【名词解释】社会病；越轨行为；自杀；自伤
2. 【简答题】简述社会病的五大特点。
3. 【简答题】简述自杀行为的分类（五个层次）。
4. 【简答题】简述迪尔凯姆（Durkheim）根据社会整合程度对自杀的四分类。
5. 【简答题】简述自杀的十大预防措施。

参考答案要点

1. **社会病：**主要由社会本身原因造成的、与社会发展和进步方向相违背的、危害人群健康的社会性现象。**越轨行为：**违背群体标准或期望的行为。**自杀：**个人在意识清楚情况下，自愿有意地采取结束自己生命的行为。**自伤：**意识清楚情况下自愿采取自我致伤/致残行为但完全没有结束生命的主观意愿。
2. (1) 必须具有社会性；(2) 产生根源主要在于社会（非个人行为或生物学特征）；(3) 对社会具有严重危害性；(4) 防治需要全社会综合施策共同努力；(5) 既是社会问题也是健康/公共卫生问题。
3. 五个层次：(1) 自杀意念（有意愿无行动）→(2) 自杀计划（形成计划无准备无行动）→(3) 自杀准备（做了准备无行动）→(4) 自杀未遂（采取行动未导致死亡）→(5) 自杀死亡（行动直接导致死亡结局）。
4. 自我性自杀（社会整合程度低）、利他性自杀（整合程度高）、失范性自杀（社会规范弱）、宿命性自杀（社会规范过强）。
5. (1) 建立国家自杀预防战略；(2) 提高人群心理健康素质；(3) 指导媒体有关自杀事件的报道；(4) 普及自杀和自杀预防知识；(5) 减少自杀机会（武器/毒物/危险场所管理）；(6) 建立预防自杀专门机构（危机干预中心/生命热线）；(7) 对医务和心理咨询工作者进行培训；(8) 提供完善精神卫生服务；(9) 加强学校和工作场所自杀预防；(10) 关注自杀死亡者亲人。